INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Emergencias y Catástrofes

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES:

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERVENCIONES DE PRIMERA RESPUESTA: "Primeros Auxilios Psicológicos/ Emocionales"

Lic. María Cecilia Bodon[1] y Lic María Alejandra Ríos[2]

Introducción:

Las situaciones de emergencias y catástrofes acompañan desde siempre a la historia de la humanidad. Las consecuencias sobre la salud física de las personas implicadas en dichos eventos son ampliamente conocidas y sobre ellas se destinan importantes recursos (humanos y económicos); sin embargo, los efectos sobre la salud mental de las poblaciones afectadas han sido menos atendidos.

La **Psicología de la Emergencia** surge como una manera de responder a esa situación y se define como **el estudio del comportamiento humano antes, durante y después de las situaciones de emergencia;** o sea, ante situaciones que ocurren inesperadamente. (Valero S. 2001)

Es necesario aclarar que un evento no es por sí mismo traumático, que lo sea dependerá de condiciones subjetivas y personales del afectado. Por ende, se puede afirmar que algunas situaciones son "traumatogénicas" (potencialmente traumáticas); es decir, que por sus características pueden provocar efectos adversos permanentes en la salud psicofísica de las personas.

Karl Slaikeu define a las crisis como un *"estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo"* (Slaikeu K., 1988, pp16).

Un incidente será crítico cuando desborde la capacidad de afrontamiento de la persona debido a la interrupción "temporaria" de sus recursos adaptativos, provocando una serie de **reacciones físicas** (cansancio, taquicardia, sudoración, etc.), **cognitivas** (confusión, falta de concentración, rumiación, etc.), **emocionales** (tristeza, culpa, irritabilidad, etc.) y de **comportamiento** (aislamiento, hiperactividad, alteraciones del sueño etc.).

[1] Lic. en Psicología UBA- Jefa de Trabajos Prácticos (Interina) Materia Clínica Psicológica y Psicoterapias, Emergencias e Interconsulta 1. Email: mcbodon@gmail.com

[2] Lic. en Psicología UBA- Ayudante de Trabajos Prácticos (Regular) Materia Clínica Psicológica y Psicoterapias, Emergencias e Interconsulta 1.Email: malerios11@gmail.com

A esas reacciones iniciales se las considera “normales”, lo que se presenta como “anormal” es el evento vivido. Es por ello que en las intervenciones que se realizan en las primeras etapas de las crisis **no se habla de “pacientes” sino de “afectados”**, distinción fundamental al momento de llevar adelante una intervención de ayuda.
El vocablo “crisis” se refiere a las respuestas de un organismo que se vio sobrepasado, en cambio cuando se hace referencia al **tipo de suceso que lo provoca** se utilizan los conceptos de urgencia, emergencia, desastre y catástrofe.
Estas palabras suelen emplearse en sentido indistinto, sin embargo es importante entender que a pesar de tener ciertos aspectos en común (amenaza, riesgo, imprevisibilidad), sus diferencias radican en relación al número de personas involucradas y la disponibilidad de recursos sociales existentes para acudir en su ayuda.

- **Urgencia o accidente**: es un suceso que afecta a una o a pocas personas, sin impacto a nivel de la comunidad y en el que los recursos existentes de asistencia son suficientes para su atención adecuada. (Ej. Un accidente de auto con pocos individuos involucrados).
- **Emergencia:** es una situación en la que el número de afectados es mayor, tiene impacto social pero en la que los recursos locales de asistencia alcanzan para cubrir las necesidades de atención adecuadamente. (Ej. Un choque de dos ómnibus de pasajeros).
- **Desastre**: es un evento causado por sucesos naturales o creados por el hombre, que provoca alteraciones intensas, involucra a gran parte de la población y en el que se agotan las estructuras de asistencia, con el consiguiente costo económico y alarma general. Incluye múltiples emergencias. (Ej. La inundación de una región).
- **Catástrofe**: es una situación que afecta a la colectividad de forma global, incluidos sus sistemas de respuestas (desastre masivo); por eso al menos en los primeros momentos no se podrá contar con ayuda institucional. Se requerirá de ayuda externa para la asistencia (Ej. Tsunami Indonesia 2004).

Los desastres y las catástrofes, a diferencia de las urgencias y emergencias, constituyen las situaciones que ocasionan mayor nivel de estrés colectivo al implicar a una gran cantidad de personas afectadas, así como el desborde de las infraestructuras destinadas a la asistencia.
En el marco de la **Psicología de la Emergencia**, según el momento en el que se intervenga y el tipo de ayuda ofrecida, se distinguen: **Intervenciones de Primer y Segundo Orden.**
Las **Intervenciones de primer orden** son aquellas que se brindan inmediatamente después de acontecido el evento traumatogénico (dentro de las primeras 72hs), situación que en algunas personas puede derivar en trauma. **Se apuntará a la recuperación del nivel de funcionamiento**

que se tenía antes de la crisis, restableciendo el equilibrio emocional y facilitando la activación de recursos de afrontamiento.

Estas intervenciones de primer orden pueden ser impartidas por personas que no necesariamente son profesionales de la salud pero que sí, indispensablemente se han entrenado y formado en la temática.

Las **intervenciones de segundo orden** son llevadas a cabo por profesionales de la salud mental y se implementan cuando las intervenciones de primer orden no han alcanzado a resolver o paliar los efectos del suceso. Estas consisten en procesos psicoterapéuticos que suelen durar varias semanas o meses y que tienen como objetivo lograr la translaboración del suceso traumático (Slaikeu, K.,1988).

En el presente artículo nos centraremos en desarrollar las intervenciones de primera respuesta también llamadas **Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) o Primeros Auxilios Emocionales (PAE)**, destacando y aclarando que esta información no suple el indispensable entrenamiento y formación para llevar adelante responsablemente esas tareas.

Intervenciones de Primera Respuesta: Primeros Auxilios Psicológicos o Emocionales (PAP/PAE)

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) o Emocionales (PAE) son intervenciones de ayuda y soporte emocionales que se implementan durante los primeros momentos de acaecida una situación crítica (primeras 72 hs.) con las personas que acaban de sufrir el impacto de una noticia, un accidente, que han sido víctimas de un atentado o vivido una catástrofe.

Constituyen la primera atención que recibirán los afectados, por eso se las enmarca dentro de las intervenciones de primera respuesta, indicadas para aplicar en las primeras fases de una situación de crisis.

No necesariamente son llevadas a cabo por psiquiatras o psicólogos, pero es fundamental que las personas que las implementen posean un entrenamiento adecuado que les permitirá saber qué hacer y qué no hacer en situaciones de este tipo.

El objetivo primordial de dichas intervenciones será proteger a las personas de sufrir daños mayores evitando la re victimización, reduciendo las complicaciones, buscando la recuperación, promoviendo el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento para lidiar con lo sucedido. (Slaikeu, C 1988, Brymer M et Al, 2006).

Debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los afectados, es fundamental como marco general de la intervención, no prometer en la intervención aquello con lo que no se va a poder cumplir.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2002), Organización Mundial de la Salud (OMS 2012), Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2014) los objetivos de las intervenciones de primera respuesta son:

- *Detener el proceso agudo de descompensación psicológica, aliviando las manifestaciones sintomáticas y el sufrimiento.*
- *Estabilizar al individuo y protegerlo de estrés adicional, reduciendo los sentimientos de anormalidad o enfermedad.*
- *Evitar complicaciones adicionales.*
- *Restaurar las funciones psíquicas y readaptar a la persona a las nuevas condiciones tan rápido como sea posible.*
- *Prevenir y mitigar el impacto del estrés pos traumático.*[3]
- *Facilitar u orientar la asistencia profesional a mediano o largo plazo si fuera necesario.*

Karl Slaikeu los acota a tres objetivos fundamentales: brindar apoyo, reducir la mortalidad y relacionar a la persona en crisis con otros recursos de ayuda (Slaikeu, 1988, pp 114).

La **gestión de una crisis** incluye 3 momentos claves: **Antes, Durante y Después.**
El primer momento, "**Antes"** (previo a las situaciones a intervenir), se refiere a todas las actividades de preparación, capacitación y entrenamiento (físico y emocional) de los profesionales que asistirán en el evento. Los integrantes de los equipos deberán conocerse y mantener contacto permanente con el fin de facilitar la distribución de tareas llegado el momento de la intervención.
El segundo momento, "**Durante",** consiste en la aplicación de los PAP/PAE propiamente dichos. Incluye todas las intervenciones focalizadas que apuntan a disminuir y paliar el impacto que la crisis conlleva: contener emocionalmente, informar y orientar, organizar y realizar un diagnóstico situacional (evaluación de riesgo).
El tercer momento, **"Después"**, (finalizada la intervención) estriba en la implementación de las técnicas de cuidados y prevención de los afectados y del autocuidado del equipo de asistencia especializado. Incluye todos los procedimientos que apunten a la reinserción de los individuos a sus tareas habituales y el seguimiento de casos específicos de riesgo que se hubieran detectado en la etapa anterior.

[3] En el **Anexo A** del presente artículo se incluyen las descripciones de los indicadores según el DSM5 para la identificación y diferenciación del Trastorno de Estrés Agudo y Trastorno de Estrés Post Traumático.

Para lograr la mayor efectividad posible existen pautas protocolarizadas que detallan secuencias de cada actuación, aplicación de técnicas específicas para el abordaje de los afectados, así como de descarga emocional destinadas a todos los intervinientes en el suceso.
Los protocolos son procedimientos consensuados que ante las situaciones de urgencia simplifican el accionar, facilitando la intervención, la toma de decisiones y protegen al equipo, no sólo en lo referido a los aspectos físicos y emocionales sino también las cuestiones legales. El marco legal deberá estar contemplado en cada actuación, ya que en ciertas ocasiones una buena intención podría contraponerse con lo legalmente estipulado (Por ej. en lo referido a los procedimientos efectuados con menores de edad).
En síntesis, siempre hay que considerar que "*Una intervención improvisada puede provocar tanto o más daño que la problemática en sí misma"* (Ministerio Salud de la Nación Argentina, 2015).

Características específicas de PAP/PAE:

Para poder comprender adecuadamente la aplicación de los primeros auxilios psicológicos/ emocionales y su efectividad, es preciso entender al ser humano como una entidad BIO- PSICO-SOCIAL.
George Engel propone el modelo "biopsicosocial" para la comprensión de los procesos salud-enfermedad, en contraposición al modelo médico tradicional (división mente-cuerpo); estableciendo la coexistencia de factores biológicos, psíquicos y sociales siempre implicados y entrelazados en el desarrollo de dichos procesos (Engel G.,1977).
A partir de ese momento se comienza a pensar al hombre como una totalidad, una unidad biopsicosocial. Esto permite comprender como, en condiciones normales ,el ser humano responde a los diversos estímulos integrando cognición y emoción; es decir que cuenta con la posibilidad de responder afectivamente y a la vez comprender, razonar y coordinar la acción de manera integrada.
El Sistema Límbico (formado por una serie de estructuras complejas ubicadas alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral) está involucrado en el control de la emoción, las motivaciones, la conducta, la iniciativa, el mantenimiento o supervivencia del individuo o de la especie, la memoria y el aprendizaje (Saavedra J., Díaz W,. Zúñiga L., Navia C., Zamora T.,2015).
En situaciones de estrés agudo, la amígdala (parte del Sistema Límbico que se encarga de procesar y almacenar las emociones) se sobreactiva y la nueva información sensorial "excesiva" no puede acceder a los circuitos de memoria y asociación; por ende se produce una disociación temporal (bloqueo de la respuesta racional) por la que pasa a primar la esfera emocional sobre el

área de la cognición. Como consecuencia de ello el afectado pierde la posibilidad de discernir con claridad mensajes, retener información y operar asertivamente. Estudios de neuroimagen permiten confirmar funcionalmente este proceso observándose la sobreactivación en el área del Sistema Límbico y el déficit de actividad en área prefrontal del cerebro (Saavedra J., Díaz W,. Zúñiga L., Navia C., Zamora T.,2015).

En consecuencia, **las intervenciones en PAP/PAE deberán considerar esta limitación temporal presente en los afectados**, ya que debido a ella, **no se encontrarán en condiciones adecuadas como para poder discernir, comprender los mensajes y actuar operativamente**. Se deberán tomar las medidas de cuidado pertinentes que puedan suplir y comprender esa limitación.

Como contrapartida, en el equipo de trabajo y en pos de una intervención eficaz, deberá producirse una "disociación técnica", también temporal, que permita en el accionar la primacía de la razón por sobre la emoción.

La preparación profesional y el entrenamiento permiten, por efecto de la repetición sistemática, **un aprendizaje de respuestas adaptativas** en el Sistema Límbico que garantizan una mayor posibilidad de activación ante las situaciones de crisis inhibiendo las respuestas límbicas emocionales y dando prioridad a respuestas que permitan el manejo exitoso de la tarea (Cea Ugarte, J.I, 2015).

Este recurso evitará que se produzcan en el equipo situaciones reñidas con los objetivos de las intervenciones y que podrían ser difíciles de manejar tales como: discutir acaloradamente, intentar hacer entrar en razón forzadamente, cortar reacciones emocionales de descarga de los afectados o mentir sobre lo sucedido.

El riesgo de quiebre de esta disociación instrumental se encuentra presente en todo momento del accionar para todos los integrantes, poniendo en riesgo la actuación del grupo de trabajo, con la consiguiente posibilidad del incrementar el número de víctimas. El autoconocimiento, la integración y comunicación efectiva entre los miembros del equipo son aspectos esenciales para evitar que ello suceda.

Para el logro de los objetivos básicos de la provisión de los primeros auxilios emocionales se procederá al:

- Establecimiento de contacto y presentación (de manera empática y no intrusiva).
- Brindar alivio, protección y contención (cubriendo las necesidades básicas y proveyendo alivio físico y emocional).
- Recogida de información (identificando las necesidades inmediatas y preocupaciones).
- Brindar asistencia práctica (para paliar las necesidades).

- Establecer conexión con las redes de apoyo (primaria y red comunitaria).
- Provisión de pautas de afrontamiento.
- Conexión con servicios externos (Si se evalúa la necesidad se debe dejar establecido el enlace con las redes de ayuda disponibles a mediano y largo plazo).

Cada uno de los principios enunciados requiere de la implementación de estrategias (Brymer M, Jacobs A, Layne C, Pynoos R, Ruzek J, Steinberg A, Vernberg E, Watson -National Child Traumatic Stress Network y National Center for PTSD, 2006):

Para promover seguridad física y emocional se ofrecerá, dentro de lo posible, la posibilidad de permanecer en un lugar apartado del escenario. Se implementarán técnicas tendientes a estabilizar a las personas en shock, se brindará la información con la que se cuenta sin hacer falsas promesas ni restar importancia a lo ocurrido como también se atenderán las necesidades básicas en cuanto comida, bebida, ayuda médica, provisión de información, etc.

Para promover la calma se procurará cuidar el confort físico y emocional de las personas afectadas. Se realizarán todas las comunicaciones que fueran necesarias en forma pausada, usando palabras adecuadas (lenguaje cognitivo) , dando la información de manera clara y sencilla reiterándolas tantas veces como sea necesario. Se escuchará a las personas que deseen hablar sin forzarlas a hacerlo.

Para ayudar a las personas a establecer conexión con su red de apoyo se harán los esfuerzos necesarios para reunir a los integrantes de las familias, mantener a los niños, siempre que sea posible, junto a sus padres, respetar las normas culturales, ofrecer ayuda religiosa (teniendo en cuenta todas las religiones implicadas) y ayudar a contactar con fuentes comunitarias de ayuda.

Para promover la Autoeficacia se animará a las personas a identificar sus necesidades, se colaborará ayudándolos a establecer las prioridades pero sin resolver los problemas por ellos, intentando promover la recuperación del control de sus vidas.

El Afrontamiento se facilitará implementando pautas psico-educativas, conectando a las personas con sus recursos personales, informando sobre reacciones básicas de estrés, normalizando las sensaciones y sentimientos que son propios por el suceso vivido, enseñando técnicas de relajación, pautas de higiene, etc.

Para promover una ayuda eficaz se brindarán datos sobre todos los recursos disponibles de atención (oficiales y extra-oficiales) y se hará formalmente la derivación a un servicio asistencial en caso de evaluar su necesidad.

El proceso por el cual se identifican a los afectados que se encuentren en mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales se lo conoce como “Screening” Psicológico o T**riage Psicológico**. Existen diferentes instrumentos que se utilizan al respecto, el más frecuente consiste en el uso de

la tarjeta de Triage Psicológica (ver Anexo B) que posibilita hacer una valorización rápida sobre la necesidad de atención, identificando el resultado de la evaluación con una etiqueta o pulsera (color rojo, amarillo o verde) que se coloca al asistido, permitiendo de esa manera que todos los profesionales que intervengan sepan a quién dar prioridad en la atención (Ruiz Muñoz,E M, 2015). También es utilizado el *Disaster-Related Psychological Screening Test* (DRPST), que cuenta con validación empírica en ciertas poblaciones (Figueroa, R., 2010).
Para garantizar la seguridad de los asistidos, es sumamente importante impedir la entrada de los medios de comunicación y curiosos que podrían ocasionarles un mayor malestar.

¿Con quiénes se interviene? Clasificación de Víctimas:

Para poder distribuir los recursos de asistencia de manera apropiada se debe poder identificar a todos los niveles de las víctimas implicadas en un suceso. Históricamente se incluían a los afectados directamente, sus allegados y al personal interviniente en la ayuda.
A medida que los desarrollos de la Psicología de la Emergencia se complejizan se fueron incorporando nuevos niveles de víctimas a esa clasificación. En 1981 Taylor y Frazer, contando con amplio consenso internacional (García Renedo, M et Al. 2007), amplían ese listado permitiendo dimensionar la magnitud del número de los afectados.

1- **Víctimas Primarias**: son aquellas personas que se encontraban ubicadas en el epicentro del desastre (heridos, fallecidos e ilesos).
   Los ilesos muchas veces son dejados sin los cuidados necesarios, ya que "aparentemente" no han sufrido daños, pero se observó que pueden aparecer complicaciones de magnitud en los días o semanas posteriores; por eso también deben ser identificados y asistidos, así como también sucede con los heridos.
2- **Víctimas Secundarias**: conformadas por los familiares y amigos cercanos de las víctimas primarias. Se calculan unas 10 personas afectadas directas por cada víctima de primer nivel.
3- **Víctimas de Tercer Nivel**: Integrado por todo el personal que interviene en el rescate y la emergencia (médicos, bomberos, psicólogos, personal sanitario, etc.), quienes -en palabras de Taylor- "*necesitan ayuda para mantener su rendimiento funcional durante algunas operaciones y hacer frente a los posteriores efectos psicológicos traumáticos*" (Taylor, A.J.W y Frazer, A.G., 1981).
4- **Víctimas de Cuarto Nivel:** Conformado por la comunidad implicada (por inmediata cercanía) en el suceso. Se deben considerar tanto a las personas que de manera desinteresada ofrecen espontáneamente su ayuda, como a las que sufren pérdidas y robos como producto del desastre.

5- **Víctimas de Quinto Nivel**: Lo integran las personas implicadas de manera indirecta, es decir "*personas que aunque no estén envueltas directamente en el área del impacto, pueden desencadenar reacciones y consecuencias psicológicas, como en el caso de los teleespectadores"* (Taylor, A.J.W y Frazer, A.G., 1981). Se ha verificado la presencia de reacciones de miedo, inquietud y angustia en sujetos que vieron imágenes de desastres sin haber estado presentes en los mismos.

   Los medios de comunicación, cuyo valor informativo no está en cuestionamiento, pueden ser también productores de víctimas de quinto nivel. Por esta razón se apela a la posibilidad de encontrar un equilibrio entre la realización de un trabajo periodístico serio y responsable y la necesidad de cumplir con criterios éticos que hagan al cuidado de las víctimas, primando el aspecto humano sobre el sensacionalismo, entendiendo que gran parte de las víctimas de este nivel son "evitables". Por ello es fundamental, limitar al máximo la circulación de ciertas imágenes en medios audio-visuales (Fernández Millán, J.M, 2013).

Taylor y Frazer (Taylor, A.J.W y Frazer, A.G., 1981) refieren **un sexto nivel de víctimas**, integrado por aquellos que podrían haber sido víctimas de primer nivel y no lo fueron por distintos motivos (Por ej. perdieron el vuelo que sufrió el accidente). En algunos casos de este nivel se corroboró que la situación referida les provocó sentimientos intensos de remordimientos o culpa. En la práctica en general a estas personas se las incluye dentro de las víctimas del quinto nivel. Lo novedoso de esta clasificación radica en la poder considerar que en una emergencia puede haber afectados con posibilidad de manifestar secuelas que requieran atención y que no han estado presentes directamente durante el suceso o que habiendo estado han resultado "ilesos" desde lo físico; así como también pueden resultar afectados los propios profesionales que participan en las tareas de rescate y ayuda.

El reconocimiento como víctimas permite la posibilidad de otorgarles ayuda y fundamentalmente diseñar medidas preventivas tendientes a la reducción del número de las mismas.

Secuencia de implementación de los PAE

Previo a la aplicación, cada integrante del equipo deberá evaluar si posee la calma y claridad de pensamiento necesarios para participar, ya que en caso de no encontrarse en condiciones óptimas, es recomendable que no participe en esa específica oportunidad.

Como **primer paso** el personal de asistencia, una vez que ha arribado al lugar del evento, **deberá ponerse al servicio de quienes estén coordinando** la tarea y trabajar de forma integrada y subordinada a ellos.

También **se deberá obtener toda la información previa necesaria**: lugar disponible donde se va a trabajar, datos fehacientes sobre lo sucedido, estar al tanto de dónde se ofrecen servicios esenciales y quiénes son los encargados de proveer la asistencia. (Instituciones y organismos intervinientes).

Se **identificarán a las personas que requieran asistencia,** aspecto fundamental para organizar la distribución del espacio existente y asegurar la atención para todos los que la necesiten (empezando por las víctimas de primer nivel).

Respecto a la asistencia a los familiares y amigos cercanos (víctimas de segundo nivel) se limitará el número a recibir según la disponibilidad de los recursos con los que se cuente (espacio y recursos humanos). Normalmente en pos de una distribución equitativa, se reciben 2 personas por cada víctima de primer nivel.

Siempre que sea posible y con consenso en el grupo de trabajo, se deberá **agrupar a las personas bajo categorías específicas.** Las variantes a considerar dependerán de las características de la población afectada, respetando pautas culturales y tradiciones de los grupos asistidos; así como también evaluando las necesidades especiales que cada grupo etáreo pueda tener (Niños, adolescentes, adultos mayores o personas con necesidades especiales).

Lugar de la aplicación

Los primeros auxilios psicológicos o emocionales **se aplican fuera de la zona donde ha tenido lugar el suceso, en un espacio seguro** lo más confortable posible (protegido de la vista y sonidos del escenario primario) para cuidar a las personas de una re-exposición innecesaria a eventos traumáticos adicionales. Debe encontrarse lo suficientemente lejos como para poder tomar cierta distancia de lo sucedido (por ejemplo donde no se escuche el ruido de ambulancias) y cercano como para que el afectado no sienta que se lo quiere alejar del lugar del incidente, con el consecuente aumento de ansiedad o angustia que ello podría provocar.

Para garantizar la seguridad y la privacidad de los asistidos es frecuente el uso de biombos que impida el contacto directo de curiosos ocasionales y distintos representantes de los medios de comunicación que podrían ocasionarles un mayor malestar.

Pautas generales para entrar en contacto directo con las víctimas

El primer contacto con los afectados es fundamental, el hacerlo de manera adecuada aumenta la receptividad de los mismos. Se deberán contemplar variantes culturales respecto al establecimiento del contacto visual, distancia física a mantener, etc.

Al acercarse para asistir a las víctimas siempre será importante solicitar permiso para hablarle, **presentarse** en primer lugar, explicitando el nombre, rol y objetivo de la intervención a realizar. También se deberá **informar** que la presencia del personal de Primeros Auxilios tiene como objetivo brindar ayuda y establecer un contrato de confidencialidad, se intentará garantizar la mayor privacidad posible, buscando el espacio que se considere de mayor protección.

Se deberá **hablar pausadamente**, utilizando frases cortas, preguntar el nombre a la persona y siempre referirse a ella utilizándolo. La actitud deberá ser calma y tolerante, sin perder el contacto visual y entendiendo que las personas están bajo el efecto de la disociación emocional, como se explicó anteriormente, por lo que a los asistidos se les dificulta la comprensión y la regulación emocional adecuada. Se deberá señalar la necesidad de lograr cierta tranquilidad para que el afectado pueda recibir la información pertinente.

Un ejemplo de establecimiento de contacto posible podría ser: *"Mi nombre es ….. pertenezco al equipo …. Estoy para ayudarle/te, Cuál es su/tu nombre? Puedo hacer algo por Ud./ vos? Necesito que se/te calmes para que pueda brindarte información. Voy a estar a disposición para lo que necesites, etc.*

Es **fundamental brindar información**, sin esperar a que las personas se acerquen a solicitarla, puesto que el desconocimiento aumenta la confusión e incrementa el malestar. Las comunicaciones se trasmiten a adultos. Siempre que se requiera asistir a menores se debe pedir autorización a un adulto responsable y de haberse tenido una conversación con un niño que se encontraba solo se les hará saber a sus familiares lo antes posible (Brymer M et Al.,2006).

El tipo de lenguaje que se utiliza se conoce como "lenguaje cognitivo". Para sintetizarlo, sería el que responde a las preguntas: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Las respuestas a esas preguntas serán la información a solicitar y transmitir.

Se debe evitar el uso del denominado lenguaje emocional, el que responde a preguntas cómo, por qué, siento que, creo que, me parece que; ya que su imposibilidad de respuesta en ese momento, tiende a aumentar la confusión y la desregulación, conduciendo a un nuevo desborde emocional.

Para establecer una adecuada comunicación es preciso tener presente que el lenguaje verbal implica sólo un porcentaje de lo que comunicamos (30%), los aspectos no verbales de la comunicación (gestos, posturas, tonos, mirada, apariencia, etc.) en estas situaciones se vuelven fundamentales. La coherencia entre ambos tipos de lenguaje es sumamente importante para lograr la confianza necesaria que otorgue alivio y contención. La forma de comunicarse es importante en toda relación interpersonal, la reacción de la persona asistida va a depender de la imagen que se le brinde (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2014).

Hay ciertas actitudes que se encuentran contraindicadas al momento de acercarse a ofrecer asistencia, tales como: tener un comportamiento intrusivo al solicitar datos, mostrarse ansioso, prometer cosas que no se podrán cumplir, mostrarse afectado emocionalmente ante las reacciones de enojo de los asistidos, tener una actitud moralista, confrontar las creencias que las personas pudieran manifestar.

Como se explicó al mencionar los objetivos ,se **identificarán las necesidades y preocupaciones prioritarias,** se brindará colaboración para ayudar a la reagrupación familiar.

Es sumamente importante atender a quienes tengan un familiar desaparecido y arbitrar todos los recursos disponibles para facilitar el reencuentro o la información sobre lo sucedido.

Se **reordenarán las necesidades y se irá ayudando a planificar cómo ir llevándolas a cabo,** fomentando siempre la conexión con sus redes de apoyo.

Contener y acompañar no implica compadecerse sino poder **brindar herramientas que le permitan a quienes están atravesando una situación crítica recuperar el control mínimo de su vida.**

Es importante brindar **información psico educativa** acerca de las reacciones físicas y psicológicas que pudieran registrarse, y que son esperables ante una situación de estrés agudo. Normalizar la presencia de las mismas colabora con su posibilidad de comprensión. Se **recomienda entregar esta información en un escrito breve** (anexo C) donde estén consignadas las posibles reacciones, los tiempos en los que se deberá proceder a pedir ayuda a un especialista si no cedieran y los datos de lugares de asistencia disponibles. El tener estas pautas por escrito permite acudir a ellas todas las veces que sea necesario verificarlas.

En este punto cabe destacar que en alguna circunstancia que, por características personales y/o tipo de afrontamiento, un afectado no logre re equilibrarse mínimamente luego de las intervenciones y por consiguiente puedan aparecer actitudes violentas por parte del mismo, se deberá decidir no seguir trabajando con él para preservar la integridad de las personas y la calma necesaria para la actuación del equipo. Se deberá dar aviso de inmediato al personal de seguridad correspondiente.

Protocolo para la comunicación de “malas noticias”

En muchas ocasiones las personas que realizan los primeros auxilios emocionales son las encargadas de comunicar a los afectados y sus familiares “malas noticias”. Esta situación implica una carga emocional tanto para quien debe dar la información como para el que la recibe.

Es un derecho de la personas recibir toda la información que se encuentre disponible (Ley 26529-PLN). Al ofrecerla siempre se deberán cuidar los aspectos legales en lo concerniente a qué se

dice y a quién se lo dice; como así también tener presentes aspectos, culturales, sociales y religiosos.

Los profesionales deberán contar con un procedimiento estipulado a seguir: (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2014, Bascuñán ML, 2013).

1- **Contar con la información clara y certera** de lo que se debe comunicar. No anticiparse a brindar información que no esté confirmada. Para una trasmisión adecuada suele ser de utilidad confeccionar previamente una reseña escrita donde conste: qué ha pasado? Cuándo? Cómo? Dónde? A Quién?.
2- Asegurarse de **corroborar la identidad** de la/las personas con las que se tiene que hablar.
3- **Presentarse,** dando nombre, explicando tareas y funciones, pedir los respectivos nombres a las personas y dirigirse a ellos usándolos en todo momento.
4- **Buscar un lugar** que brinde el ambiente lo más acogedor y privado que sea posible.
5- Contar **con material auxiliar** que pudiera ser necesario (Pañuelos de papel, agua, sillas, teléfono, etc.).
6- **Con actitud empática**, mostrando interés por lo sucedido, haciendo contacto visual directo, se procederá **primero a preguntar por la información que las personas posean**, de esta manera podrán aclararse informaciones falsas o distorsionadas que pudieran circular.
7- **Se brindará la información necesaria** con un lenguaje claro y conciso, evitando detalles innecesarios y en ninguna circunstancia dando falsas esperanzas.
   Si se debe notificar una muerte, debe hacerse de manera clara, sin usar metáforas o referencias indirectas.
8- Se deberá **permanecer el tiempo que sea necesario**, ofreciendo seguir hablando o esperando al momento en el que la persona lo considere oportuno, nunca se debe imponer una ayuda. Se respetarán los silencios siempre permaneciendo al lado del asistido para que se sienta acompañado y respetado en su dolor. No se dejará a la persona sola.
   Podrían darse reacciones emocionales de descarga (llorar, gritar, maldecir), es fundamental en esta etapa entender esas respuestas como parte de una reacción normal y validarlas como tal.
   La información por más dura que sea siempre aporta calma y colabora con la recuperación del control.
9- Se **responderá de manera concisa todas las preguntas** y necesidades que pudieran surgir.

10- Siempre que se deban brindar **datos específicos** (Ej. dirección del hospital al que deben concurrir) deben darse **por escrito** ya que la situación de shock puede impedir retener esa información de forma correcta.

Si por algún motivo la persona que asiste debe retirarse del lugar, esa situación deberá comunicarse al asistido indicándole quién ocupará su función en su ausencia.

Existe consenso sobre una **secuencia de reacciones esperables** que se hacen presentes ante la comunicación de noticias y que implican un duelo por hacer. Estas fueron descriptas inicialmente por Elizabeth Kubler Ross (1975), conocerlas permite comprender y acompañar adecuadamente a los asistidos en cada una de ellas

- **Etapa de Negación, shock**: Es una de las respuestas inmediatas a la recepción de la noticia, constituyendo una de las maneras posibles que permiten amortiguar el impacto de la misma. La información es imposible de ser aceptada por lo que se niega la realidad de la noticia devastadora. Son comunes las frases como “no es posible”, “no es cierto”,”tienen que estar equivocados”, etc.

  Si bien en los inicios del duelo es una respuesta normal, permanecer en ella es perjudicial, ya que impide la aceptación de lo sucedido.
- **Etapa de Rabia, explosión**: En esta etapa la persona reconoce lo sucedido pero no lo acepta, presenta un comportamiento hostil con el ambiente, la ira es el sentimiento predominante.

  Es fundamental comprender este momento como parte del proceso y no juzgar a la persona por ciertas reacciones emocionales que quizás podrían resultar inadecuadas.
- **Etapa de la Negociación**: se da una aceptación parcial de lo sucedido pero necesitando algo a cambio. Se desea volver a la situación previa a lo sucedido, concentrando la atención en aquello que se podría haber hecho para evitarlo. La frase más común que resume esta etapa es “¿Qué hubiera sucedido si…?” Es un último intento de aliviar el dolor.
- **Etapa de Depresión:** en esta etapa se comprende y acepta lo sucedido con profundo dolor. Son frecuentes síntomas de desinterés, apatía, desánimo.
- **Etapa de Aceptación**: la tarea de esta etapa es la resignificación de lo sucedido como parte de la trama de la vida, aprender a vivir con ello, la persona vuelve a conectarse con sus rutinas. Esa experiencia ya forma parte de la historia personal, se acepta la realidad y se convive con ella.

Es fundamental para no incrementar el sufrimiento emocional de las víctimas ni las reacciones de desborde, no dar las “malas noticias” de manera rápida, ni en lugares inadecuados (Ej. pasillos plagados de gente), como tampoco dejar a la persona sola, minimizar sus reacciones de sufrimiento, intentar evitar los estallidos emocionales o mostrarse desbordado por la tarea.

Existen protocolos de intervención a seguir para dar información de noticias de manera telefónica, como así también para el acompañamiento al reconocimiento de cuerpos o pertenencias. El detalle de los mismos excede el presente trabajo.

Medidas de protección del equipo

A medida que las intervenciones en emergencias se fueron institucionalizando comienzan simultáneamente a verse las huellas "negativas" que el trabajo puede dejar en los trabajadores que realizan la asistencia. Generalmente son personas que funcionan adecuadamente bajo las responsabilidades a que son sometidos pero **la magnitud de la experiencia estresante puede superar en algunas circunstancias las defensas del individuo, volviendo insuficientes a los procesos habituales de adaptación**. En ocasiones se pueden evidenciar respuestas similares a las de las personas asistidas, inclusive Trastorno de Estrés Postraumático y Depresión.

El conocimiento de esta situación determinó que se incluyera al personal de asistencia como víctimas de tercer nivel en la clasificación general.

Las estadísticas indican que entre un 3% y un 7% de casos, los profesionales pueden llegar a desarrollar el Trastorno de Estrés Postraumático (Hodgkinson y Stewart, 1998) a consecuencia de su labor.

En el ámbito local la Lic Alicia Galfasó[4] hace especial hincapié en la necesidad del cuidado de los recursos humanos de asistencia, instruyendo en el conocimiento de las limitaciones que todo personal interviniente debe reconocer para un accionar eficiente y sostenido a lo largo del tiempo, diferenciando de esta manera a los "héroes" de los "profesionales".

En situaciones de desastre las exigencias siempre son superiores a las posibilidades de respuesta, por lo que es imprescindible reconocer y evaluar la situación sin comprometer al personal interviniente (tanto en lo referido a su salud física como emocional).

Un profesional adecuadamente entrenado, tiene la posibilidad de aliviar el dolor, responder a la emergencia de la mejor forma posible, reconociendo limitaciones propias y del equipo; garantizando la posibilidad de trabajo futuro.

Es frecuente que en el accionar se sienta la presión de seguir actuando aún cuando la situación exceda posibilidades reales. La sociedad "pide héroes", capaces de "inmolarse" sin medir riesgos, en pos del éxito y reconocimiento por la tarea realizada.

Para minimizar los efectos del estrés antes, durante y con posterioridad al desastre, es fundamental contar con la capacitación y entrenamiento adecuado sobre el accionar en un incidente crítico.

[4] Lic. en Psicología especialista en Psicotraumatología y Psicología de la Emergencia. Directora del Posgrado Primeros Auxilios Emocionales en emergencias, urgencias y desastres. Cátedra de Medicina Legal. Facultad de Medicina. UBA

Trabajar con un compañero (BuddySystem) como forma de apoyo mutuo incrementa los niveles de seguridad y eficiencia.

Las tareas se deben desarrollar en **turnos de entre 4 y 6 horas** de duración, con períodos de descanso, destinados a la alimentación y relajación, cada dos horas. En los lugares de trabajo sometidos a un alto nivel de estrés (Ej. depósito de cadáveres) se recomienda no permanecer más de dos horas seguidas (Guía Didáctica de Intervención Psicológica en Desastres. España. 2005).

Los miembros del equipo deberán **conocer técnicas apropiadas de autocuidado** para el manejo del estrés (técnicas de control de la respiración, estimulación sensorial, uso de un plan de manejo de estrés) y siempre someterse a una sesión de **Defusing (**ver apartado técnicas) al finalizar cada intervención, con el objetivo de apuntar a reducir la posibilidad del "desgaste por empatía" que constituye la mayor amenaza a la integridad de los equipos.

Como técnica de prevención secundaria, si se lo considera necesario, y hasta 72hs posteriores al evento se puede implementar el **Debriefing Psicológico** (CISD-Critical Incident Stress Debriefing). Técnica desarrollada inicialmente por Mitchel (1983) para la prevención de Síndrome de Estrés Postraumático. En la misma, tanto los aspectos cognitivos como emocionales del trauma pueden ser explorados logrando la integración del relato traumático en forma lógica y cronológica para evitar la revictimización constante y comenzar a abrir la posibilidad de habilitar el futuro (Guía Didáctica de Intervención Psicológica en Desastres. España .2005).

Se la considera útil tanto para el personal interviniente como para las víctimas de primer nivel. Existe cierta controversia respecto a la utilidad tanto del Defusing como del Debriefing Psicológico para la prevención den Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT). La confusión mayor parecería originarse en las variaciones que se han ido generando respecto de la modalidad original. Los expertos recomiendan la explicitación del procedimiento utilizado y la profundización de las investigaciones (Santacruz Escudero J.M, 2008); así como entender que **los beneficios nunca pueden esperarse de la aplicación de una sola técnica sino a la totalidad de un procedimiento general** (Galliano, S et Al., 2003).

Se podrá indicar seguimiento psicológico y psicoterapia específica para aquellos integrantes del equipo en los que se detecte la necesidad, así como se considerará la posibilidad o no del otorgamiento de una licencia laboral o la rotación de tareas por un tiempo estipulado, hasta tanto pueda retornar a las propias.

Algunas técnicas básicas a emplear en PAP/PAE

Dentro del repertorio de intervenciones de primera respuesta existen diferentes técnicas que apuntan a facilitar el logro de los objetivos de la tarea. Algunas de ellas están destinadas al manejo de los afectados, y otras apuntan al autocuidado del equipo interviniente en el suceso.

Colaboran en la recuperación del control emocional de las víctimas en estados de desborde, desorganización, excitación psicomotriz, etc. Incluyen elementos de Psicología Cognitiva, Mindfulness, técnicas de respiración y relajación, entre otras.

Ejercicios respiratorios

Existe evidencia científica (Cea Ugarte, J.I. et Al, 2015) sobre el efecto beneficioso que tiene el uso de ejercicios respiratorios voluntarios para el manejo del estrés y la ansiedad, logrando resultados similares al uso de ansiolíticos (Kholi,A et Al.,2001). Por dicha razón y dada su facilidad de implementación, sin contraindicaciones médicas, sumado a su bajo costo, es que se vuelven fundamentales tanto para el alivio de los asistidos como para el personal del equipo de asistencia.

Son indicados en las situaciones en que la persona no se encuentre en condiciones de contener su emoción y con el objetivo de colaborar en la recuperación de la calma, equilibrando los ritmos respiratorio y cardíaco, alterados por el impacto de la crisis.

Procedimiento:

1- Presentarse explicitando el nombre, rol y objetivo de la intervención. Hablar pausadamente, con frases cortas, preguntar el nombre a la persona y señalar la necesidad que se tranquilice para que pueda recibir la información pertinente.
2- Con el consentimiento de la víctima, sin movimientos bruscos, colocarse de costado plantándose fuertemente con ambos pies, apoyando una palma de la mano sobre hombro y la otra en el antebrazo. Estas dos zonas corporales son las recomendadas para entrar en contacto con los afectados sin comprometer más desequilibrio emocional para la víctima ni la posibilidad de romper la disociación instrumental para el profesional.
3- Con una mano sobre el hombro y la otra tomándola desde el dorso de la mano y apoyándola sobre el pecho, se lo ayuda a controlar el ritmo de la respiración pidiéndole que inspire y expire sintiendo cómo el aire ingresa en el organismo (respiración alta).
4- Se baja la mano a la altura del abdomen (siempre hablando lento y pausado) corroborando el ingreso del aire en la zona.
5- Luego de dos respiraciones profundas y guiadas, el reflejo vagal (caída de los hombros) indicará que la persona ha comenzado a tranquilizarse y puede estar en condiciones de recibir la información y pautas necesarias que el equipo crea convenientes.

Con posterioridad, se recomendará el uso de este ejercicio de respiración controlada (de manera auto administrada) al menos dos veces al día y en toda situación en la que se requiera la

recuperación de la calma. Ayuda a impedir la acumulación de estrés y por ende facilita la conciliación del sueño.

Plan para el manejo del estrés

Este plan es **indicado tanto para los integrantes del equipo como para los afectados.** Ayuda a la normalización de niveles tolerables de estrés, atendiendo a necesidades de los tres planos "bio- psico-social" (Engel, 1977) alterados por la situación experimentada.

Se elabora un plan "semanal" y la propuesta es sostenerlo activo y continuo entre 6 y 8 semanas. El lapso sugerido está en relación a los tiempos en que un Trastorno de Estrés Agudo podría derivar en Estrés Pos Traumático.

Permite instalar una rutina, que pueda ser sostenida, colaborando con el inicio de un procesamiento saludable del duelo, ya que en toda situación de crisis se da una cancelación del tiempo futuro.

Se va confeccionando junto con la persona asistida, ubicando días de la semana y horarios en la que puede realizar cada actividad y con el compromiso de mantenerlo, en principio, durante 4 semanas. Luego de ese lapso, si es necesario se prolonga.

El plan incluye actividades sencillas, tales como:

- Dieta sana, agradable, respetando 4 comidas diarias. En situaciones de alto estrés es posible que se desordene la rutina alimentaria, por ello se remarca la importancia de llevarlas a cabo en un ambiente grato, como por ej. sentarse a la mesa, usar vajilla, etc.
- Realizar 10 minutos diarios de caminata atenta (conciente). Se realiza sin celular e implica aprender a captar y ver el "aquí y ahora". Consiste en ir hablando mentalmente y ponerle palabras a todo lo que se ve, estimulando el área de la atención y ayudando a reducir la presencia de los pensamientos intrusivos.
- Realizar una actividad placentera, creativa durante una hora y una vez a la semana. Por ej. escribir, pintar, tejer. Debe implicar cierto nivel de creatividad y no ser pasiva, como por ej. mirar una película. Las actividades creativas estimulan áreas cerebrales de ambos hemisferios (Rendón Uribe, M A, 2012).
- Realizar una actividad social una vez a la semana, registrar qué va a hacer y con quiénes va a realizarla.
- Realizar ejercicios de respiración durante 2 a 5 minutos, dos veces al día. Proporcionan calma y ayudan a lograr una buena calidad del sueño.

De acuerdo a la situación en la que se encuentren los afectados se pueden considerar ciertas variaciones al plan, por ej. se puede recomendar que tanto la caminata como la actividad creativa sean realizadas en compañía de otra persona si se evalúa necesario.

Técnica de Estimulación Sensorial

Es una técnica de Mindfulness que ayuda a la mente a volver al presente y permitir liberar tensión acumulada. La sobreestimulación recibida en una situación de emergencia provoca un nivel de estrés elevado ocasionando dificultades cognitivas (pensamientos intrusivos). La mente toma conciencia a través de los sentidos y ellos provocan las emociones, por eso una técnica que permita sincronizar los sentidos primarios con estímulos positivos facilitará la calma. Ellen Hendriksen (2018) señala que un ejercicio (denominado 5x1) permite la focalización en los sentidos de manera simultánea situando a la persona en el presente.

La técnica de estímulos sensoriales (Galfasó A., 2015) tiene la virtud de ser autoadministrable, su implementación insume una duración máxima de 10 minutos. Apunta a movilizar estímulos sensoriales en forma simultánea como forma de descontaminar los sentidos que han sido expuestos en el desarrollo del evento, evitando que se acumulen sensaciones desagradables. Simultáneamente y luego de respirar profundamente para recuperar el ritmo cardíaco adecuado, manteniendo los ojos abiertos, se debe:

- Ingerir un alimento que le resulte sabroso (no habitual)
- Tomar alguna bebida predilecta (sin alcohol y no habitual)
- Pensar en algo que produzca alegría y/o placer (Por ej. Un recuerdo agradable, un paisaje, etc.)
- Escuchar con auriculares algún tema musical preferido.
- Estimular el olfato con alguna fragancia placentera.
- No relajarse, ni meditar (Puede revictimizar).

Es recomendable como técnica de autocuidado, su sencillez y autoadministración permite que sea realizada en los momentos en que cada integrante del equipo pueda sentirse abrumado por la situación. Cada profesional deberá contar con los elementos necesarios como parte de un kit de emergencias.

Técnica de Defusing (Mitchell 1983):

La técnica de Defusing (Mitchell, 1983) se implementa como **sesión de descarga, con el objetivo de minimizar los efectos de la experiencia en los equipo de trabajo,** debido al riesgo por la exposición a la disociación peri traumática (necesaria para desarrollar la tarea pero contraproducente si se sostiene en el tiempo).

Se realiza en un lugar tranquilo, fuera de la mirada de otras personas, inmediatamente concluida cada intervención y previo al retorno a los hogares. Es coordinada por una persona entrenada, generalmente el jefe del equipo.

Consiste en una sesión informal, semiestructurada. Conducida en una atmósfera de apoyo mutuo, donde los participantes tendrán oportunidad para describir sentimientos y reacciones (des shocking) así como evaluar estrategias para la resolución de problemas a fin de que la productividad del trabajo no se vea disminuida ni deteriorada (Guía Didáctica e Intervención Psicológica en Desastres. Ministerio del Interior. España, 2005).

Durante su desarrollo no serán admitidas las críticas destructivas, la duración es entre 20 minutos y una hora como máximo y se realiza en grupos entre 6 y 15 personas bajo estricta reserva de confidencialidad.

Al finalizar se chequea cómo se encuentran los participantes y se provee apoyo a aquellos que estén más afectados.

Procedimiento: (Galfasó, A. 2015 y Valero Valero, M et Al. 2007)

1º Paso consiste en el armado grupal de lo sucedido (¿Qué pasó?)

Dispuestos en círculo, cada integrante (inclusive el coordinador) de manera sucesiva irá relatando lo sucedido. No se admiten interrupciones ni expresiones emocionales fuertes.

Este paso no consiste en una ventilación emocional sino en la reconstrucción del relato grupal en un nivel cognitivo, para obtener la información lo más completa posible del suceso.

El coordinador aclara algún punto que haya sido cuestionado.

2º Paso se analiza la intervención respondiendo: ¿Que hicimos mal? ¿Por qué?

Por medio de intervenciones espontáneas se realiza un análisis conjunto en el que se van mencionando aspectos que se consideran que fueron realizados de manera inadecuada, por Ej. si faltó algún material, si falló la comunicación del equipo, etc. El objetivo de esta etapa es tomar nota de ciertas dificultades para evitarlas en el futuro sin culpabilizar a ningún miembro.

3º Paso se analiza la intervención poniendo acento en aquello que fue efectivo, respondiendo ¿Qué hicimos bien? ¿Por qué?

De manera espontánea los integrantes del grupo rescatan aquellas cosas que resultaron adecuadas en el accionar. Este paso contribuye a reforzar la interconexión del equipo, asumiendo sus logros. Por ej. se menciona si llegaron a tiempo, si tenían los elementos apropiados, si se pudieron organizar satisfactoriamente, etc.

4º Paso. Se evalúan necesidades grupales e individuales. ¿Qué necesitamos/necesito?.

Primero se plantea a nivel grupal y luego a nivel individual, especialmente si hubiera algún integrante del equipo que se encontrara muy afectado por el trabajo realizado.

Antes del cierre se recordarán las pautas de afrontamiento de estrés generales y refuerzo positivo (aquello que ha servido en otras ocasiones vividas).

Al cerrar la sesión el coordinador agradece la presencia y participación de los asistentes.

La utilidad del Defusing se encuentra cuestionada debido a que sus protocolos no son rígidos y carecen de rigor científico. Hay quienes consideran que no tiene ninguna utilidad y quienes

sostienen que colabora mitigando los efectos negativos que puede provocar el hecho de haber llevado a cabo tareas ante un suceso desastroso (Valero Valero, M et Al, 2007).
Valero Valero M et A (2007) lo consideran "*no solo conveniente, sino también recomendable…, con el fin de que, por un lado la persona interviniente pueda expresar cómo se ha sentido por lo ocurrido y por su intervención y, por otro lado, que tanto el individuo como el resto del grupo pueda analizar y cuestionar el trabajo realizado, potenciar los aspectos positivos del mismo y desterrar las acciones poco recomendables" (pp. 48).*

Conclusiones

El cabal reconocimiento de las posibles y potencialmente graves consecuencias psicológicas que se derivan de las situaciones de emergencias y catástrofes, abre la necesidad de profundizar en estrategias e intervenciones de primera respuesta que ayudarán a aminorar el impacto en la salud psicológica de los afectados.
El personal interviniente instruido en primeros auxilios emocionales debe estar presente en las situaciones referidas para atender a los afectados, ya que son altas las probabilidades que aparezcan conductas disfuncionales que pueden mitigarse con ayuda apropiada. La misma podrá reducir la multiplicación innecesaria de víctimas y la aparición de patologías severas tales como los cuadros depresivos y el Trastorno de Stress Post traumático (TEPT).
Si bien no es requisito indispensable poseer un título de grado para la actuación en emergencias y desastres, sino un entrenamiento específico; consideramos que sería muy importante incluir la temática en la currícula académica de las carreras de grado vinculadas a la salud mental.
Para concluir, es necesario volver a destacar que este artículo intenta transmitir contenidos básicos sobre la temática expuesta, pero de ninguna manera suple la formación y entrenamiento necesarios para actuar responsable y eficazmente en emergencias y catástrofes.

Referencias Bibliográficas

Araya Molina, C. (2013) *Psicología de la Emergencia*. Santiago de Chile. Chile. Psicoprev.

Argentina. Ministerio de Salud. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (2015). *Salud Mental: recomendaciones para la intervención ante situaciones de emergencias y desastres*. Buenos Aires.

Asociación Americana de Psiquiatría (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM 5).* 5ª Ed. Arlington, VA

Bascuñán, M L (2013) *Comunicación de "Malas Noticias"* en Salud. Revista Médica Clínica las Condes. Santiago. Chile. Vol 24 pp 685-693

Bessoles, P. (2006). *Psicoterapia Post Traumática. Contribución a una teorización psicodinámica de Defusing y Debriefing psicológica.* En Subjetividad y procesos cognitivos. Pp. 53 -68. UCES.

Brymer M, Jacobs A, Layne C, Pynoos R, Ruzek J, Steinberg A, Vernberg E, Watson P (National Child Traumatic Stress Network y National Center for PTSD). (2006) *Primeros Auxilios Psicológicos: Guía de Operaciones Prácticas*, 2da edición. Disponible en: http://www.nctsn.org y Http://www.ncptsd.va.gov.

Cea Ugarte, José Ignacio, González-Pinto Arrillaga, Asunción, & Cabo González, Olga M.ª. (2015). *Efectos de la respiración controlada sobre los síntomas de estrés y ansiedad en una población de 55 a 65 años: estudio piloto. Gerokomos*, *26*(1), 18-22. https://dx.doi.org/10.4321/S1134-928X2015000100005

Cohen, R y Ahearn, F (1989) *Manual de la atención de salud mental para víctimas de desastres.* Mexico. Harla

Cortés Trujillo, E.G (2002) "*La percepción psicológica del riesgo y el desastre" Cap2: – Aspectos Neuropsicológicos*. Cuadernos de Crisis Vol 1 Nro 2 pp15-39. 2003 www.cuadernosdecrisis.com › docs › cdc_002

Costa Marcé,M. Gracia Blanco. (2002) *Debriefing y tría psicológica en intervención en crisis: una revisión.* Psiquis (Madr.). Vol 23 Nro 5: pp 198-208.España

Dirección General de Protección Civil y emergencias (2005). *Guía Didáctica de Intervención Psicológica en catástrofes. Unidad didáctica 7. Intervención psicológica con intervinientes en emergencias*. Madrid. España Nipo:126-05-061-0

Engel, G (1977).*The need for e new medical model: a challenge for biomedicine. Science* . New Series Vol 196 Nro 4286, pp 129-136

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja (2012) *Primeros auxilios psicológicos*. Ginebra

Fernandez Millan, Juan M. (2013) *Gestión e intervención psicológica en emergencias y catástrofes*. Madrid. España. Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.),

Figueroa, Rodrigo A, Marín, Humberto, & González, Matías. (2010). *Apoyo psicológico en desastres: Propuesta de un modelo de atención basado en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Revista médica de Chile*, *138*(2), 143-151. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872010000200001

Figueroa, R,Cortés, P, Accatino, L y Sorensen, R. *Trauma psicológico en la atención primaria: orientaciones de manejo.* Rev Mev Chile; 144: 643-655

Galfaso, A. *Manual de Primeros Auxilios Emocionales en Urgencias, Emergencias y Desastres para Primeros Respondientes* . Centro Psicotraumatológico Argentino (no publicado). Bs As

Galliano, S.; Cervera Goizueta, M; Parada Torres, E., *El CIPR (Procesamiento y Recuperación tras Incidentes Críticos). Un marco para la intervención postrauma y el desarrollo del*

debriefing psicológico. Cuadernos de Crisis Vol 1 Nro 2 pp12-14. 2003 www.cuadernosdecrisis.com › docs › cdc_002

García Renedo, M; Gil Beltrán, JM; Valero Valero M. (2007) *Psicología y desastres: aspectos psicosociales.* Castelló de la Plana: Publicaciones de la Universidad de Jaume I. KRK Ediciones

Hernández Marin, I E y Gutiérrez López, L P (2014). *Manual básico de Primeros Auxilios Psicológicos.* UIPC CUCS. Guadalajara. México.

Hendriksen, E. Ph (2018). *How to be yourself?* USA. Macmillan.

Hodgkinson, Y Stewart, M. *Coping With Catastrophe: A Handbook of Post-disaster Psychological Aftercare Routleedge*. London. 1998
http://files.unicef.org/paraguay/spanish/Primeros_auxilios_sicologicos_IFRC.pdf
ISBN 978 92 4 354820 3 (Clasificación NLM: WM 401)

Kohli A, Varma VK, Nehra R. *Comparison of efficacy of psychorelaxation and pharmacotherapy in generalized anxiety disorder*. J Person Clin Studies. 2001;16:43-

Kübler Ross, E.(1975) *Sobre la muerte y los moribundos.* Barcelona. España Ediciones Grijalbo

Kübler Ross (1997-2005) *La rueda de la vida*. Biblioteca Lascasas 1. Disponible http:// www.index-f.com/las casas7documentos7lc0018.php

Ley 24421 (PLN) .Ley Nacional de Atención Primaria de la Salud Mental. Boletín Oficial. República Argentina. 3 de Mayo de 2001

Ley 26529 (PLN) Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Boletín Oficial. República Argentina. 20 de Noviembre 2009

Ley 26657 (PLN). Ley Nacional de Salud Mental. Boletín Oficial. República Argentina. 29 de Mayo 2013

Madrigal Bonilla, A. (2012) "*Disociación como defensa al trauma: caso clínico de fuga disociativa".* Revista Cúpula. Vol 26(2) 9-18. San José de Costa Roca. ISSN 1659 3871

Mitchell, J.T., (1983), *When Disaster Strikes: The Critical Incident Stress Debriefing Process*, Journal of Emergency Medical Services, 8, 36-39.

Ochoa Cepero. M.J (2015) *Psicología de Emergencias: Una nueva Profesión*. Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud. N.º 21, pp. 173-187, 2015

Organización Mundial de la Salud (2000). *Prevención del Suicidio. Un instrumento para trabajadores de atención Primaria en salud. Trastornos Mentales y Cerebrales* Departamento de Salud Mental y Toxicomanías Organización Mundial de la Salud. Ginebra. Manuscrito no publicado

Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation y Visión Mundial Internacional (2012). *Primera Ayuda Psicológica: Guía para trabajadores de campo*. Ginebra. Disponible en: http://whqlibdoc. who.int/publications/2012/9789243548203_spa.pd

Organización Mundial de la Salud, OMS, (2013). *Salud mental: un estado de bienestar.* Recuperado el 18 de junio de 2014. Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/

Organización Panamericana de la Salud (2010).*Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Desastres: Guía para equipos de respuesta*. Disponible en :http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc18061/doc18061.htm»

Organización Panamericana de la salud –OPS. (2016) *Guia de la Salud Mental en Situaciones de Desastres y Emergencias*

Osorio Vigil, A. (2017) *Primeros Auxilios Psicológicos*. ALFEPSI. Integración Académica en Psicología.Vol 5. Nro 15. ISSN: 2007-5588

Pineda Marín, Claudia, & López-López, Wilson. (2010). *Atención Psicológica Postdesastres: Más que un "Guarde la Calma". Una Revisión de los Modelos de las Estrategias de Intervención. Terapia psicológica*, *28*(2), 155-160. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082010000200003

Prados Castillejo JA Quesada Jiménez F. (1998) *Guía sobre cómo dar malas noticias*. FMC. Vol 5(4): 238-50

Rendón Uribe, M. (2012). *Creatividad y cerebro: bases neurológicas de la creatividad. Aula, 15*, 117-135. Recuperado de http://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/8946

Ruiz Muñoz, E. (2015) *El Triage Psicológico ¿Una herramienta para el psicólogo de Emergencias?* Cuadernos de Crisis. Nro 14 Vol 11. Pp 63-69 http://www.cuadernosdecrisis.com/docs/2015/numero14vol1_2015

Saavedra Torres,J S; Diáz Cordoba, W J; Zúñiga Cerón, L F; Navia Amézquita, C. A. Zamora Bastidas, T.O. (2015). *Correlación funcional del sistema límbico con la emoción, el aprendizaje y la memoria*. Morfolia UCO ISSN 20119860– Vol. 7 - No. 2 –pag 29 a 44 ISSN electrónico 2011-9860.

Santacruz Escudero, José Manuel .*Una revisión acerca del debriefing como intervención en crisis y para la prevención del TEPT (trastorno de estrés postraumático)* Revista Colombiana de Psiquiatría, vol. 37, núm. 1, 2008, pp. 198-205 Asociación Colombiana de Psiquiatría Bogotá, D.C., Colombia

Slaikeu, K. (1988) *Intervención en Crisis. Manual para Práctica e Investigación* (1988) México. El Manual Moderno.

Taylor, A.J.W.y Frazer R, A.G. (1981). *Psychological sequelae of operation overdue following the dc-10 aircrash in Antarctica*. Victoria University, Wellington, New Zealand: Victoria University of Wellington Publications in Psychology, 27.

Valero S. *Psicología en emergencias y desastres* (2001). Lima (Perú): Editorial San Marcos

Valero Valero, M.; Gil Beltrán,J M; García Renedo,M (2007). *Profesionales de la Psicología ante un desastre.* Castelló de la Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I, DL,

Anexo A

Trastorno de Estrés Agudo y Trastorno de Estrés Postraumático:

La mayoría de las personas que han sido víctimas de una situación de desastre / emergencia no desarrollarán psicopatología. Sin embargo es preciso poder distinguir dos de los cuadros que podrían presentarse y que en ocasiones se prestan a confusión.

Toda situación traumatogénica causará en la persona, un cuadro de estrés agudo.
Según Figueroa et Al (2010) *"La mayoría de las víctimas de los desastres presenta síntomas psicológicos transitorios, sólo una minoría desarrolla psicopatología de largo plazo, siendo el TEPT y la depresión mayor las enfermedades más frecuentes".*
Es fundamental, en primer lugar, poder identificar los síntomas para poder intervenir en consecuencia.
En la versión utilizada actualmente del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM5 (2012) se crea un capítulo especial referido a Trastornos relacionados con traumas y estresores en el que se incluyen al Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT), anteriormente incluido en el DSM IV dentro de los Trastornos de Ansiedad y al Trastorno de Estrés Agudo (TEA).
En términos generales la distinción entre TEA y TEPT está centrada en la variable temporal de la sintomatología psicofísica.

El **Trastorno de Estrés Agudo (TEA)** aparece como consecuencia de la exposición a un evento traumático; surge como respuesta a un estrés excepcional. Es un cuadro de carácter agudo, transitorio, en el que las manifestaciones clínicas aparecen dentro del plazo de algunas horas de haber sido experimentado el suceso, con una permanencia mínima de tres días y máxima de seis semanas.

Según el DSM 5 los síntomas del Trastorno de Estrés Agudo (TEA)- 308.3 (F43.0)
Son:

A. **Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual (real o amenaza), en una (o más) de las formas siguientes:**
1. Experiencia directa del suceso(s) traumático(s).
2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido a otros.
3. Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo.
4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) traumático(s) (p. ej. socorristas). No aplicándose a exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, excepto esté relacionada con el trabajo.

B. **Presencia de nueve (o más) de los síntomas siguientes de alguna de estas cinco categorías, que comienza o empeora después del suceso(s) traumático:**
Síntomas de intrusión:
1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso(s) traumático(s
2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del sueño está relacionado con el suceso(s).
3. Reacciones disociativas (p. ej., escenas retrospectivas) en las que el individuo siente o actúa como si se repitiera el suceso(s) traumático(s). (La expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente.)
4. Malestar psicológico intenso o prolongado o reacciones fisiológicas importantes en respuesta a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s).

Estado de ánimo negativo:
5. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (p. ej., felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos).
Síntomas disociativos:
6. Sentido de la realidad alterado del entorno o de uno mismo (p. ej., verse uno mismo desde la perspectiva de otro, estar pasmado, lentitud del tiempo).
7. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso(s) traumático(s) (debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas).
Síntomas de evitación:
8. Esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s).
9. Esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s).
Síntomas de alerta
10. Alteración del sueño
11. Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna provocación), agresión verbal y física
12. Hipervigilancia.
13. Problemas con la concentración.
14. Respuesta de sobresalto exagerada.

C. La duración del trastorno (síntomas del Criterio B) es de tres días a un mes después de la exposición al trauma. **(Al menos deben persistir 3 días**)

D. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica y no se explica mejor por un trastorno psicótico breve.

En tanto, el **Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)** es un trastorno crónico, de gravedad, que no remite sin ayuda profesional, surge como respuesta excepcional debido a un hecho traumático y **sus síntomas tienen una duración mayor a un mes.**

Según el DSM5 el Trastorno de estrés postraumático. 309.81 (F43.10) se define por:

A. **Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una (o más) de las formas siguientes**:
1. Experiencia directa del suceso(s) traumático(s).
2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido a otros.
3. Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo (Violento o accidental).
4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) traumático(s) (p. ej. socorristas). No aplicándose a exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, excepto esté relacionada con el trabajo.

B**. Presencia de uno (o más) de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso(s) traumático(s), que comienza después del suceso(s) traumático(s):**

1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso(s) traumático(s).
2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del sueño está relacionado con el suceso(s) traumático(s).
3. Reacciones disociativas (p. ej., escenas retrospectivas) en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso(s) traumático(s). (La expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente.)
4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s).
5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s).

C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso(s) traumático(s), que comienza tras el suceso(s) traumático(s), se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes:
1. Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s).
2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al
Suceso (s) traumático(s).

D. **Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso**(s) traumático(s), que comienzan o empeoran después del suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por dos (o más) de las características siguientes:
1. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso(s) traumático(s) (amnesia disociativa).
2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo (p. ej., “Estoy mal,” “No puedo confiar en nadie,” “El mundo es muy peligroso,” “Tengo los nervios destrozados”).
3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso(s) traumático(s) que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás.
4. Estado emocional negativo persistente (p. ej., miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza).
5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas.
6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás.
7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (p. ej., felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos).

E**. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso(s) traumático**(s), que comienza o empeora después del suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por dos (o más) de las características siguientes:
1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia sin motivación (verbal o física)
2. Comportamiento imprudente o autodestructivo.
3. Hipervigilancia.
4. Respuesta de sobresalto exagerada.
5. Problemas de concentración.
6. Alteración del sueño (p. ej., dificultad para conciliar o continuar el sueño, o sueño inquieto).

F. La duración de la alteración (Criterios B, C, D y E) es superior a un mes.

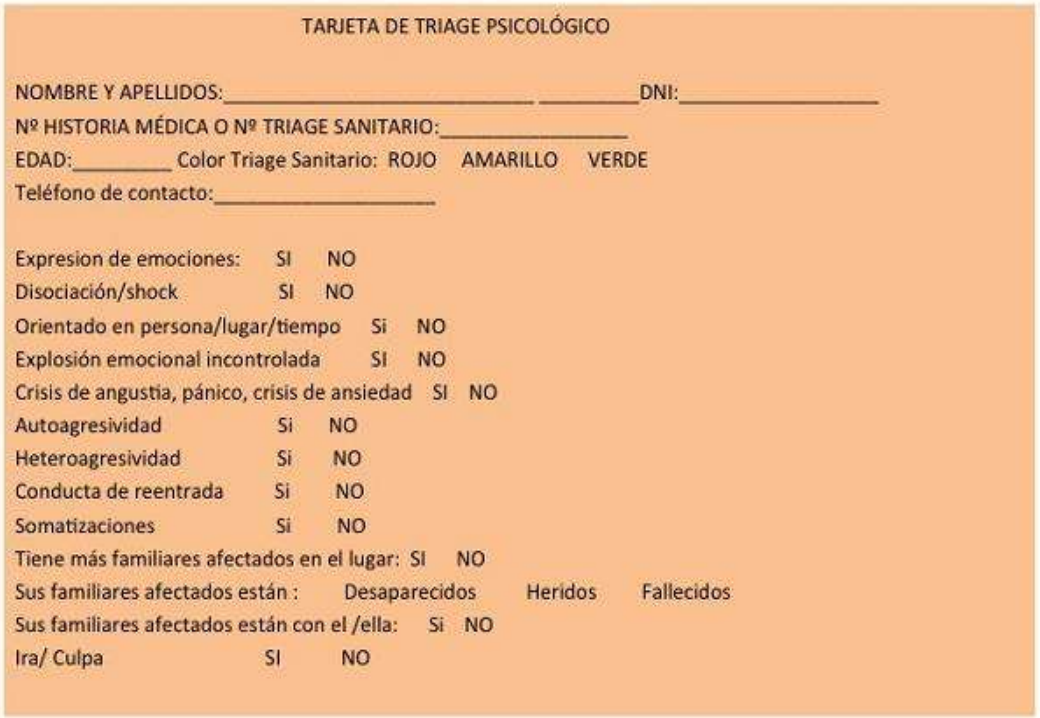
G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

H. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., medicamento, alcohol) o a otra afección médica.

Especificar si:
Con síntomas disociativos: Los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático y, además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las características siguientes:
1. Despersonalización: Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal (p. ej., como si se soñara; sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo, o de que el tiempo pasa despacio).
2. Desrealización: Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno (p. ej., el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño, distante o distorsionado).
No atribuible a consumo sustancias o afección médica
Especificar si: Con expresión retardada: cuando los síntomas se dan luego de 6 meses del acontecimiento Trastorno de estrés agudo

Las intervenciones de Primeros Auxilios recaen sobre las manifestaciones de estrés agudo con la intención de prevenir la instalación de un cuadro de TEPT con el riesgo que implica para la salud integral de un individuo.

ANEXO B: Tarjeta de Triage Psicológico (Ruiz Muñoz, E.M., 2015)



TARJETA DE TRIAGE PSICOLÓGICO

NOMBRE Y APELLIDOS:_____ _____DNI:_____
Nº HISTORIA MÉDICA O Nº TRIAGE SANITARIO:_____
EDAD:_____ Color Triage Sanitario: ROJO AMARILLO VERDE
Teléfono de contacto:_____

Expresion de emociones: SI NO
Disociación/shock SI NO
Orientado en persona/lugar/tiempo Si NO
Explosión emocional incontrolada SI NO
Crisis de angustia, pánico, crisis de ansiedad SI NO
Autoagresividad Si NO
Heteroagresividad Si NO
Conducta de reentrada Si NO
Somatizaciones Si NO
Tiene más familiares afectados en el lugar: SI NO
Sus familiares afectados están : Desaparecidos Heridos Fallecidos
Sus familiares afectados están con el /ella: Si NO
Ira/ Culpa SI NO

Anexo C: Secteraría de Gobierno de Salud. Ministerio de Salud y Desarrollo Social República Argentina. Folleto Cuidado de la salud en Emergencias y Desastres

¿Cuándo consultar en el centro de salud?

Si las sensaciones de malestar persisten por varias semanas o te afectan demasiado y no te permiten retomar tu rutina habitual, buscá ayuda en el centro de salud más cercano.

En tu localidad:

CUIDADO DE LA SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

ALGUNAS CLAVES PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN Y RECUPERAR LA RUTINA COTIDIANA

0-800-222-1002
www.salud.gob.ar/dinesa

dinesacomunica@salud.gob.ar
(011) 4801-1623
J. Salguero 3457 CABA

Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

Estas reacciones son esperables cuando una persona pasa por situaciones críticas. Lo más importante es cuidarte y cuidar a quienes te rodean. Por eso, te recomendamos:

Si atravesaste una situación de emergencia o desastre, es probable que tengas algunas reacciones fuera de lo común y que sientas cambios en tus emociones, conductas y pensamientos, e incluso algún malestar físico.

- Desgano, irritabilidad, cambios de humor, insomnio, pesadillas.
- Ansiedad, estado de alerta, miedos, nerviosismo, frustración.
- Sobresaltos, mareos, náuseas, taquicardia, tensión muscular.
- Confusión, desorientación, falta de concentración.
- Consumo problemático de alcohol o sustancias psicoactivas.

Los niños, niñas y adolescentes también se ven afectados por las situaciones críticas y requieren de acompañamiento especial. Prestá atención a cambios en sus conductas y sentimientos, o a otras señales que te llamen la atención.

- Conversar con otras personas sobre lo que te pasa.
- Manifestar tus sentimientos.
- Mantenerte ocupado/a y retomar lo antes posible tus rutinas y actividades cotidianas.
- Participar en actividades que te hagan sentir útil.
- Apoyar a las personas que te rodean, sobre todo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Pedir información sobre los lugares y organismos cercanos donde recurrir para resolver las diferentes necesidades.
- Proponerte pequeñas metas y objetivos que puedas cumplir a corto plazo.

BIBLIOGRAFÍA

- BODON, M. C. y RÍOS, M. A. *Emergencias y catástrofes: características de las intervenciones de primera respuesta "Primeros Auxilios Psicológicos/Emocionales".*[1]

[1] Uso con fin académico.

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Lo Traumático

Rev Med Chile 2016; 144: 643-655

Trauma psicológico en la atención primaria: orientaciones de manejo

RODRIGO A. FIGUEROA[1,2], PAULA F. CORTÉS[2], LUIGI ACCATINO[1], RICHARD SORENSEN[3]

Management of psychological trauma in primary care

Exposure to traumatic events is frequent in the general population and psychiatric sequelae such as post-traumatic stress disorders are common. The symptoms of psychiatric sequelae after trauma are vague, with multiple psychological and physical symptoms, which can confuse the health care professional. This paper seeks to facilitate the work in primary care, providing practical information about the diagnosis, initial management and referral of patients who have suffered traumatic experiences. Some early interventions and treatments are suggested.

(Rev Med Chile 2016; 144: 643-655)

Key words: *Practice Guidelines as Topic; Primary Health Care; Psychological trauma; Stress Disorders, Post-Traumatic; Trauma and Stressor Related Disorders.*

[1]Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
[2]Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), Santiago, Chile.
[3]United States Air Force.

Fuente de apoyo financiero: Este artículo recibió apoyo financiero de la Corporación Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) a través del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN)-FONDAP Nº 15110017/2011. La institución no tuvo influencia en el diseño, preparación o revisión del manuscrito. No se declaran conflictos de interés por parte de ninguno de los autores.

Recibido el 24 de julio de 2015, aceptado 1 de abril de 2016.

Correspondencia a:
Dr. Rodrigo A. Figueroa
Centro de Salud Mental, Centro Médico San Joaquín, Red de Salud UC Christus.
Av. Vicuña Mackenna 4686, Macul, Santiago, Chile.
rfiguerc@uc.cl

De acuerdo al DSM-5[1], trauma es definido como cualquier situación en la que una persona se vea expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima directa, cercano a la víctima o testigo. El CIE-11, próximo a ser publicado, lo conceptualiza como cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente amenazante u horrorizante que probablemente producirá un malestar profundo en la mayoría de las personas[2,3].

La frecuencia de las experiencias traumáticas en la población general es alta. En Chile aproximadamente 40% de la población ha experimentado un trauma alguna vez en su vida[4], lo que ubica a nuestro país en una situación intermedia comparado con México (80%), Estados Unidos de Norteamérica (50%) y Alemania (20%)[5-8].

Los traumas pueden dejar varias secuelas psiquiátricas como Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), depresión y trastornos de ansiedad, entre otros[9] (Tabla 1). La alta comorbilidad del TEPT[10], su multiplicidad de formas de presentación[11,12] y la resistencia natural de los pacientes y clínicos a hablar del trauma tornan común el subdiagnóstico de éste, a pesar de que se han descrito prevalencias de alrededor de 12% en la Atención Primaria de Salud (APS)[13–15].

Del total de personas que vive un trauma, aproximadamente 14% desarrollará un TEPT[10], siendo mayor en aquellos ocasionados por la acción intencional de terceros (ej. violaciones, asaltos, guerra, terrorismo, etc.). En Chile la mayoría de los casos de TEPT son producto de accidentes de tránsito o muerte violenta de un ser querido[4], ocasionando una pérdida de 19.869 años de vida saludable por muerte prematura o discapacidad (AVISA)[16], lo que ubica a este trastorno en la posición 44 del ranking de enfermedades que más aportan a la carga de enfermedad del país. En el mundo, el TEPT aporta 0,2% de la carga global de enfermedad, al igual que el cáncer cervicouterino[17]. Además de los costos individuales, las secuelas emocionales de los traumas producen múltiples dificultades psicosociales como problemas maritales[18,19], legales[10], disfunción familiar[20,21], desempleo, abuso de alcohol[8] y suicidio[22]. Su prevalencia varía mucho según el país estudiado:

Tabla 1. Trastornos del espectro postraumático, basado en Moreau y Zisook (2002)[9]

Trastornos de adaptación
Trastorno de estrés agudo
Somatización (trastornos somatomorfos)
Duelo complicado
Trastornos de la personalidad
Trastornos del ánimo
Trastornos de ansiedad
Trastorno de estrés postraumático Subclínico Complicado
Trastornos disociativos*

*Aunque no se menciona en el artículo de Moreau y Zisook (2002)[9], los trastornos disociativos se consideran una secuela de eventos traumáticos extremos[65].

mientras que en México 12,2% de la población ha presentado TEPT alguna vez en su vida[5], en Chile sólo lo ha hecho 4,4%[4].

Entre los factores de riesgo conocidos se encuentra el sexo femenino, los antecedentes psiquiátricos[23], una alta percepción de riesgo vital durante el trauma y posteriormente al trauma una baja percepción de apoyo social, presencia de secuelas físicas y alta percepción de estrés psicosocial[24]. Adicionalmente, se han encontrado factores de riesgo relacionados con el bajo nivel socioeconómico, educacional, de salud y de seguridad social. Es importante señalar, sin embargo, que ninguno de estos factores incrementa el riesgo tanto como para predecir quién desarrollará un TEPT[24,25]. Aproximadamente 40% de las personas que desarrolla un Trastorno de Estrés Agudo durante el primer mes post-trauma evoluciona hacia un TEPT[26-28]. Un tercio de aquellos que desarrollan un TEPT continúa sintomático una década después[28].

Dada la alta frecuencia de los traumas en la población general y su significativo impacto en salud pública es importante que los profesionales de la APS estén sensibilizados respecto al tema y sean capaces de sospechar, detectar y manejar las reacciones inmediatas y secuelas de largo plazo del trauma. Los profesionales APS se encuentran en una posición crítica del sistema de salud que los transforma en un eslabón esencial en el continuo de cuidados que requiere esta población. Esto cobra aún mayor relevancia en un país como Chile, frecuentemente afectado por desastres naturales como terremotos e inundaciones, donde la respuesta comunitaria es fundamental[29,30]. En esa línea, este trabajo tiene como objetivo entregar información práctica para el personal APS, de modo de facilitar su trabajo cuando les corresponda atender a personas que hayan vivido experiencias traumáticas (Figueroa RA, Bas C, Padilla O, Cortés PF. Social determinants of health and PTSD after the 2010 earthquake in Chile: Datos no Observaciones no publicadas. XVI Congreso Mundial de Psiquiatría, Madrid, 2014).

Reacciones emocionales y trayectorias después de un trauma

Durante los primeros días o semanas después de una situación traumática la mayoría de las personas experimenta reacciones emocionales intensas y perturbadoras, como insomnio, labilidad emocional, irritabilidad, recuerdos intrusivos sobre el evento y/o aversión a claves que recuerden el trauma, entre otras[31] (Tabla 2). Todas estas reacciones se consideran "reacciones normales frente a una situación anormal" y no constituyen necesariamente un signo de algún trastorno. Se han descrito cuatro trayectorias de evolución[32]: a) resiliente, observada en personas que son capaces de continuar sus rutinas familiares, laborales y sociales con un mínimo nivel de perturbación (35-65%); b) de recuperación, en personas que luego de un período de fuerte perturbación inicial se recuperan al cabo de algunos meses (15-25%); c) retardada, cuando luego de varios meses de mantener un funcionamiento relativamente normal la persona enferma (0-15%); y d) crónica, cuando rápidamente se produce un deterioro del funcionamiento y el paciente no se vuelve a recuperar (5-30%) (Figura 1). Adicionalmente y en el largo plazo, un grupo significativo de los afectados por experiencias traumáticas podría desarrollar "crecimiento postraumático", fenómeno caracterizado por cambios positivos en la relación con uno mismo, los demás y la filosofía de vida[33]. Lamentablemente, hoy no es posible predecir durante los primeros días y semanas después de un trauma quiénes desarrollarán una u otra trayectoria, ni si desarrollarán crecimiento

Tabla 2. Reacciones emocionales, cognitivas, físicas e interpersonales comunes frente a experiencias traumáticas recientes

Reacciones emocionales
• Estado de *shock*
• Terror
• Irritabilidad
• Sentimiento de culpa (hacia sí mismo y hacia otros)
• Rabia
• Dolor o tristeza
• Embotamiento emocional
• Sentimientos de impotencia
• Pérdida del disfrute derivado de actividades familiares
• Dificultad para sentir alegría
• Dificultad para experimentar sentimientos de amor y cariño por otros
Reacciones cognitivas
• Dificultades para concentrarse
• Dificultades para tomar decisiones
• Dificultades de memoria
• Incredulidad
• Confusión
• Pesadillas
• Autoestima decaída
• Noción de autoeficacia disminuida
• Pensamientos culposos
• Pensamientos o recuerdos intrusivos sobre el trauma
• Preocupación
• Disociación (ej. visión túnel, estado crepuscular de conciencia, sensación de irrealidad, dificultades para recordar, sensación de separación del cuerpo, etc.)
Reacciones físicas
• Fatiga, cansancio
• Insomnio
• Taquicardia o palpitaciones
• Sobresaltos
• Exaltación
• Incremento de dolores físicos
• Reducción de la respuesta inmune
• Dolores de cabeza
• Perturbaciones gastrointestinales
• Reducción del apetito
• Reducción del deseo sexual
• Vulnerabilidad a la enfermedad
Reacciones interpersonales
• Incremento en conflictos interpersonales
• Retraimiento social
• Reducción en las relaciones íntimas
• Alienación
• Dificultades en el desempeño laboral o escolar
• Reducción de la satisfacción
• Desconfianza
• Externalización de la culpa
• Externalización de la vulnerabilidad
• Sensación de abandono o rechazo
• Sobreprotección

Adaptado de *Common Reactions After Trauma*, del *National Center for PTSD, U.S Department of Veterans Affairs64*.

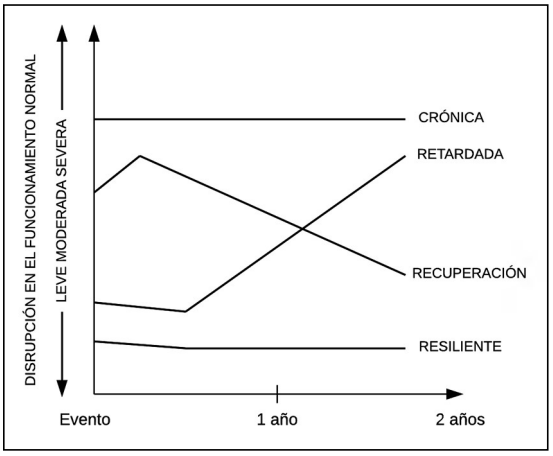


Figura 1. Trayectorias típicas de disrupción en el funcionamiento normal a lo largo del tiempo luego de un evento potencialmente traumático (adaptado con permiso de Bonano, 2004).

postraumático, por lo que el manejo del trauma será inespecífico en las primeras dos semanas y recién incorporará técnicas específicas a partir de la tercera[34].

Manejo durante las primeras dos semanas post-trauma

Durante las primeras dos semanas luego de un evento traumático el tratamiento de elección son los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), que corresponden a "una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda"[35,36]. Se trata de una estrategia de ayuda humanitaria inespecífica que se considera de elección por su bajo riesgo de iatrogenia, por su simpleza (no necesita ser profesional de la salud mental quien la aplique) y porque promueve varios factores "informados en la evidencia" que de acuerdo a varios expertos favorecerían la resiliencia (seguridad, calma, autoeficacia, conexión y esperanza)[37]. Es una técnica poco estructurada, adaptada al paciente y su cultura, pero que en la práctica, y con fines operativos, la resumiremos en cinco acciones: a) ofrecer un tiempo razonable de escucha activa (10-20 min), que puede ser definida como "poner toda la atención de uno en la otra persona y comunicarle que estamos interesados y preocupados" a través de un lenguaje corporal atento, un seguimiento adecuado de lo

que el paciente dice y conductas reflejo[38], como copiar o repetir las posturas, gestos o palabras que la persona utiliza; b) ofrecer ayuda concreta para lograr la calma, lo que puede efectuarse con técnicas de reentrenamiento de la respiración[39] apoyadas incluso por aplicaciones móviles[40,41], contracturas musculares progresivas de Jacobson[42,43] u otras técnicas de relajación (Tabla 3); c) ofrecer apoyo en sistematización y priorización de necesidades inmediatas como contacto con familiares, información, protección financiera, asistencia legal, abrigo, etc.; d) ofrecer apoyo para satisfacer las necesidades prioritarias, activando las redes de apoyo y de seguridad social disponibles; y e) ofrecer psicoeducación respecto a las reacciones normales frente al trauma, cómo ayudarse y ayudar a otros, cuáles son los signos de alarma y dónde buscar ayuda. Como podrá notar el lector, cada una de estas acciones es una oferta, que sólo será implementada si el paciente la acepta voluntariamente. En la Tabla 4 se pueden ver ejemplos típicos de frases apropiadas para cada una de las cinco acciones de PAP mencionadas.

Aunque los PAP son efectivos para lograr restituir la calma en la mayoría de las personas, en algunos casos no serán suficientes. En esos casos excepcionales podría justificarse el uso de psicofármacos como antipsicóticos o benzodiazepinas en dosis bajas por períodos de pocas semanas. Es muy importante tener cuidado con el uso de benzodiazepinas porque podrían aumentar la incidencia de TEPT, desinhibir la agresividad/impulsividad y facilitar o agravar un cuadro de abuso o dependencia de sustancias, además de interferir el proceso de psicoterapia cuando se requiera tratamiento definitivo. Su uso prolongado también aumenta el riesgo de caídas, deterioro de la memoria, accidentes, problemas de aprendizaje y sueño no reparador, además de ser inefectivas en el tratamiento de las secuelas emocionales crónicas del trauma[44]. Adicionalmente, existe alguna evidencia no concluyente señalando que podrían aumentar el riesgo de demencias[45], por lo que desaconsejamos enfáticamente utilizar esta familia de medicamentos como primera opción para el manejo agudo del trauma reciente. La quetiapina en dosis de 25 mg al día dividida en tres dosis u otros antipsicóticos a titular según respuesta son una mejor alternativa, aunque también deben ser utilizados por períodos breves. Sugerimos derivar inmediatamente a urgencia psiquiátrica a aquellos pacientes en que exista ideación suicida o agresividad marcada hacia terceros, catatonía, psicosis o algún trastorno psiquiátrico previo grave que pueda descompensarse en forma severa, ya que todas esas condiciones requieren manejo especializado (Figura 2).

Por último, es recomendable aplicar durante las primeras dos semanas post-trauma alguna escala autoaplicada de síntomas de TEPT y depresión como la PTSD Checklist (PCL)[46] y el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II)[47].

Tabla 3. Técnica de reentrenamiento de la respiración, adaptada de Foa, Hembree y Rothbaum (2007)[40]

Explíquele al paciente detalladamente la lógica del ejercicio: *"La forma como respiramos modifica nuestras emociones. Cuando botamos el aire nos relajamos más que cuando inspiramos (al contrario de lo que se suele creer), por lo que podemos entrar en un estado de calma si prolongamos el tiempo en que nuestros pulmones están vacíos…"*
Explíquele y demuéstrele al paciente la mecánica del ejercicio: *"El ejercicio se trata de que usted inspire en cuatro tiempos, exhale en cuatro tiempos y aguante cuatro tiempos más antes de volver a inspirar". Ahora mire como yo lo hago…* [hágalo usted mismo]
Acompañe al paciente a hacer el ejercicio: *"Ahora lo hará usted, y yo lo acompañaré recordándole cómo debe hacerlo. Inspire… dos, tres, cuatro… exhale, dos, tres cuatro… aguante, dos tres, cuatro…"* [repita el ciclo por uno o dos minutos acompañando al paciente]. *"Mientras exhala puede pensar en la palabra calma"*
Indíquele al paciente que lo haga diariamente por diez minutos, tres veces al día (mañana, tarde y noche) y cada vez que se sienta angustiado. Puede ayudarse con la aplicación *Breath pacer* o *Paced Breathing* disponible para celulares: *"Le voy a pedir que realice este ejercicio durante 10 minutos todos los días en la mañana al despertar, después de almuerzo, antes de irse a dormir y cada vez que sienta que está comenzando a angustiarse mucho. Mientras más use esta técnica, más fácil será la próxima vez que la use"*

Tabla 4. Ejemplos de frases útiles durante la implementación de los diferentes componentes de los Primeros Auxilios Psicológicos

Escucha activa	*"Depende de si usted quiere hacerlo o no, por supuesto… usted siempre podrá decidir, pero si quiere hablar con alguien sobre esto yo encantado de escucharle"*
Promoción de calma y relajación	*"Ya pasó… ahora está a salvo… está en el consultorio y aquí lo vamos a cuidar"* *"Me informó carabineros que el peligro ya pasó"* *"Es difícil pensar con claridad cuando uno está bajo tanto estrés… le propongo que hagamos primero una pausa con unos ejercicios de relajación, y luego le ayudaré a armar un plan"*
Apoyo en la sistematización y priorización de acciones y necesidades	*"¿Cuál cree que es el problema más importante de resolver primero?"* *"¿Qué cosas le han ayudado en el pasado cuando ha tenido que lidiar con tanto estrés?"* *"Obviamente son muchos problemas juntos que sería bueno ordenar para ir uno por uno… si quiere puedo ayudarle a hacerlo"* *"Entiendo que se sienta sobrepasado. Veamos si podemos identificar al menos tres cosas sobre las que tiene actualmente control para focalizarnos en ellas"*
Apoyo en el contacto con familiares, amigos y servicios de apoyo social	*"Se ha visto que ayuda mucho para estar mejor compartir con amigos y familiares… pasar tiempo juntos, acompañados"* *"¿Existirá algún momento en la semana en el que pueda dedicarse regularmente a compartir con su familia y amigos?"* *"Entiendo que quizás usted desconfíe de los servicios públicos de apoyo, pero si más adelante cambia de opinión, quisiera que sepa cómo contactarlos"* *"No tengo información sobre la situación de sus hijos, pero veamos si podemos averiguar algo sobre ellos en las páginas de búsqueda de personas o con la policía…"* *"Si le surge alguna duda más adelante, puede venir a preguntarme, o quizás se anime a llamar al teléfono gratuito Salud Responde (600 360 7777), donde alguien podrá orientarle las 24 h del día, los siete días de la semana"*
Psicoeducación	*"Todas esas sensaciones que está experimentando son muy comunes después de una experiencia así. La mayoría de las personas que han vivido una situación tan estresante las presentan por días e incluso semanas, pero luego se van yendo. No significan que esté perdiendo la cabeza o que sea débil… ya va a ver que se le van a ir pasando"* *"Preocuparse de usted, y pasar un tiempo de relajo junto a su familia puede ser muy útil durante estos días difíciles"* *"Afortunadamente los seres humanos solemos salir adelante de este tipo de situaciones, por más duras que parezcan, por lo que tengo confianza en que usted podrá superar todo esto…"* *"Iremos controlando su evolución en las próximas semanas. Normalmente este malestar va disminuyendo con los días y semanas, por lo que tengo confianza en que todo esto irá pasando poco a poco"* *"Lo felicito… todo eso que ha hecho es estupendo para salir adelante. Me alegro de ver como va tomando decisiones y saliendo adelante"* *"Durante estas dos primeras semanas evite pasar pegado a la tele viendo noticias sobre el terremoto… y evite que sus niños hagan lo mismo"* *"Estar más emotivo, quizás con un poco de insomnio, no poder parar de pensar en lo que pasó, más temeroso, más irritable, por momentos más retraído… todo eso es normal. Preocúpese si con los días eso no va pasando o si aparecen ganas de morir, hacerle daño a otros, si aparecen crisis de pánico repetidas, si ve que algún conocido suyo pierde contacto con la realidad… en esos casos venga o tráigalo inmediatamente"* *"Durante estos días pueden darle más ganas de beber alcohol, fumar o quizás usar otra droga… Evítelo y reemplácelo por deporte, algún hobbie, yoga o meditación, que se ha visto son más efectivos para superar momentos difíciles"*

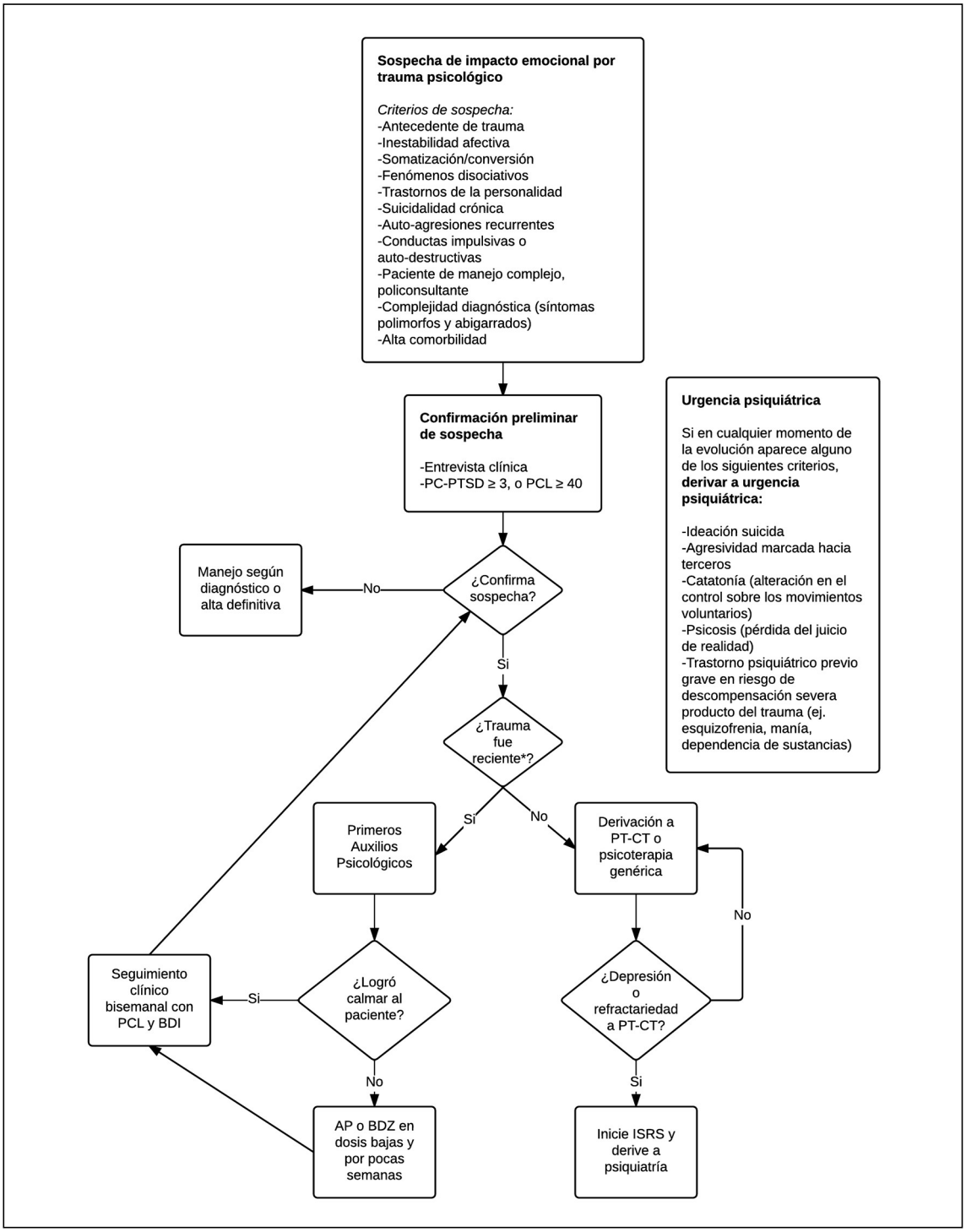


Figura 2. Algoritmo de manejo del trauma psicológico en la atención primaria de salud. AP: antipsicóticos; BDI: *Beck Depression Inventory*; BDZ: benzodiazepinas; ISRS: inhibidores selectivos de la serotonina; PC-PTSD: *primary care PTSD screening*; PLC: *post-traumatic stress disorder checklist*; PT-CT: psicoterapias centradas en el trauma. *Trauma reciente: hace menos de dos semanas.

Aunque estos instrumentos están diseñados para medir síntomas de trastornos ya consolidados, su aplicación precoz servirá para tener un nivel basal de sintomatología contra la cual objetivar cambio sintomático posterior.

Manejo a partir de la tercera semana post-trauma

A partir de la tercera semana el manejo dependerá del nivel de disfunción que produzcan los síntomas post-traumáticos y su evolución. Si los síntomas no son muy disruptivos y van disminuyendo paulatinamente (lo que se puede objetivar con las escalas PCL y BDI), bastará con adoptar una conducta expectante, efectuar psicoeducación y hacer seguimiento. Por el contrario, si los síntomas son muy disruptivos, llegando a configurar un Trastorno de Estrés Agudo, un Trastorno de Estrés Postraumático u otro trastorno del espectro postraumático (aunque sólo sea subclínico), o si los síntomas se mantienen estables en el tiempo en vez de disminuir como se esperaría, el tratamiento de elección es alguna de las Psicoterapias Centradas en el Trauma (PT-CT) basadas en la evidencia, como Terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, de sus siglas en inglés) o Terapia Cognitivo Conductual Centrada en el Trauma[48,49]. Esta recomendación se fundamenta en que estas herramientas terapéuticas son las que han demostrado mayor efectividad (incluyendo como comparación otras modalidades de psicoterapia y psicofármacos), han sido probadas en diversos escenarios (accidentes vehiculares, desastres naturales, agresiones físicas y sexuales, entre otros), y presentan menores tasas de efectos adversos[49]. Las PT-CT suelen requerir 8 a 15 sesiones semanales de 60 min, por lo que los tratamientos suelen tardar dos a tres meses, logrando tasas de efectividad con números necesarios a tratar (NNT) ≤ 4 para casos simples[50]. En las sesiones se le pide al paciente que recuerde con todo detalle el trauma para así desensibilizar y reprocesar las reacciones emocionales en un ambiente seguro y controlado como es el de la consulta. También se incluyen ejercicios de exposición *in vivo*, que consisten en un enfrentamiento real a situaciones, personas o lugares que puedan estar siendo evitados (ej. pasar por la esquina donde fue el accidente o asalto), lo que se realiza de manera gradual. Además se identifican, cuestionan y modifican los pensamientos, significados e interpretaciones distorsionadas relacionadas con el evento, intentando reemplazarlas por pensamientos más positivos (ej. "yo fui culpable" se reemplaza por "no tenía como saberlo"), se hace psicoeducación y se entregan herramientas de auto-relajación[39,51]. En el caso de EMDR, todo lo anterior es facilitado a través de estimulación bilateral alternante visual, auditiva o táctil[52], que aunque no se sabe bien como funciona, parece contribuir al reprocesamiento emocional de los recuerdos traumáticos[53]. Lamentablemente en Chile son pocos los profesionales capacitados para aplicar estas intervenciones[54], por lo que, en su defecto, la alternativa en nuestro medio será la psicoterapia convencional que se aplica habitualmente en consultorios, la que también han demostrado efectividad, aunque menor[48].

Aquellos pacientes con comorbilidad depresiva y aquellos refractarios a las PT-CT requerirán psicofármacos. En estos casos los Inhibidores Selectivos de la Serotonina (ISRS) son el tratamiento de elección, de preferencia sertralina y paroxetina por contar con mayor evidencia de efectividad[49]. Otros pacientes podrían requerir manejo coadyuvante con antipsicóticos y/o estabilizadores del ánimo (ej. pacientes psicóticos, con trastornos disociativos, con mucha inestabilidad afectiva o muy impulsivos). En todos los casos en que sea necesario adicionar fármacos a la psicoterapia sugerimos derivar a psiquiatría para manejo por especialidad, ya que se podrían requerir intervenciones que se escapan al foco del quehacer de la APS.

Trastorno de estrés postraumático

El TEPT, aunque no el único, es el cuadro más característico de los trastornos post-trauma. En la Tabla 5 se resumen los síntomas del TEPT de acuerdo al DSM-5 y el CIE-11, este último a ser publicado en 2017. Durante el primer mes post-trauma estos síntomas suelen estar presentes en forma moderada, llegando a considerarse patológicos sólo si son muy intensos y se acompañan de síntomas disociativos como amnesia, despersonalización o desrealización, en cuyo caso se configura un Trastorno de Estrés Agudo. Sólo si los síntomas se mantienen más de un mes se configura un TEPT propiamente tal, lo que resalta el hecho

Tabla 5. Síntomas del TEPT, de acuerdo al DSM-5 y CIE-11

DSM-5	CIE-11*
Presencia de ≥ 1 síntoma de intrusión recurrente, involuntario y perturbador relacionado al trauma como pesadillas, recuerdos, reacciones disociativas (ej. *flashbacks*), malestar psicológico y fisiológico frente a claves evocativas del trauma	Reexperimentación del traumas en el presente en forma de recuerdos, *flashbacks* o pesadillas vívidas e intrusivas, acompañadas de fuertes y abrumadoras emociones como miedo u horror y sensaciones físicas intensas
Evitación persistente de ≥ 1 estímulo relacionado al trauma, como recuerdos, sentimientos o claves externas (ej. personas, lugares, cosas)	Evitación de pensamientos, recuerdos, actividades, situaciones o personas evocativas del trauma
Alteraciones negativas en ≥ 2 cogniciones o emociones, como incapacidad para recordar partes importantes del trauma, disminución del interés de participar en actividades, sentimientos de desapego y distanciamiento de otros, creencias persistentemente negativas, culpa injustificada o un estado afectivo negativo	Percepción persistente de peligro, manifestada en hipervigilancia o sobresaltos frente a ruidos repentinos
Alteración significativa del estado de activación o reactividad fisiológica, consistente en ≥ 2 fenómenos como conducta irritable o agresiva, conducta imprudente o auto-destructiva, hipervigilancia, sobresaltos, desconcentración o alteraciones del sueño	Los síntomas deben durar por lo menos varias semanas
Los síntomas deben durar ≥ 1 mes	Los síntomas deben producir un deterioro significativo del funcionamiento
Los síntomas deben causar malestar significativo o deterioro del funcionamiento	Especificar TEPT complejo si se cumple además lo siguiente: a) La exposición a traumas fue repetida o prolongada y con pocas o ninguna posibilidad de escape (ej. tortura, esclavitud, genocidio en campos de concentración, violencia intrafamiliar prolongada, maltrato infantil sexual o físico repetido) b) Existen dificultades profundas y graves en la regulación emocional c) El paciente presenta creencias persistentes acerca del sí mismo como insuficiente, fracasado o incapaz, acompañado de sentimientos de vergüenza, culpa e impotencia en relación al trauma d) Existen dificultades persistentes para mantener relaciones interpersonales e intimar
Se especifica subtipo disociativo, si existe despersonalización o desrealización significativas	
Se especifica subtipo retardado, si comienza después de seis meses post-trauma	

*El CIE-11 se espera que sea publicado el año 2017. La versión actual que se presenta corresponde a una versión "beta", es decir en construcción y sujeta a posibles modificaciones.

que este cuadro es un trastorno de la recuperación natural del trauma. Este concepto es clave, porque enfatiza la tendencia espontánea a la recuperación emocional y no patologiza el malestar inicial de las personas luego de un evento traumático.

Sospecha de trastorno de estrés postraumático

Se debe sospechar secuelas psicológicas de eventos traumáticos en toda persona con inestabilidad afectiva, somatización/conversión, fenómenos disociativos, trastornos de la personalidad, suicidalidad crónica, auto-agresiones, conductas impulsivas o auto-destructivas, pacientes de manejo complejo o policonsultantes, complejidad diagnóstica (síntomas polimorfos o abigarrados) o cuando se cuente con antecedentes de trauma en la biografía. El diagnóstico de TEPT no es fácil cuando es crónico[14], ya que el antecedente del trauma suele perderse en el tiempo, olvidarse o confundirse entre muchos otros hechos traumáticos. Además los pacientes y los profesionales de la salud suelen evitar hablar de experiencias traumáticas por el malestar que ocasiona hacerlo, o porque simplemente no vinculan esas experiencias con los síntomas actuales, ignorando el hecho que las experiencias traumáticas aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, dolor lumbar, asma, problemas estomacales, dolores crónicos

músculo-esqueléticos, entre otros[55,56]. Una situación que engloba estas características puede ser encontrada en la Tabla 6.

Como muchos de estos pacientes presentan trastornos de la personalidad, en especial del tipo *borderline*[57], pueden producir rechazo por parte de los profesionales de la salud, y resistencia a indagar en su biografía. Esto se ve fuertemente agravado por la escasez de tiempo asignado para cada consulta en la APS. Los pacientes también pueden ocultar sus experiencias traumáticas por vergüenza o culpa, y la alta comorbilidad con trastornos del ánimo, ansiosos, somatomorfos, entre otros, suele complejizar aún más el diagnóstico. Un 80% de los pacientes con TEPT tienen dos o más diagnósticos asociados, como depresión, abuso de sustancias o fobias[8]. Dado que el perfil del paciente descrito es común en la APS, para facilitar el diagnóstico se recomienda utilizar de forma rutinaria herramientas de tamizaje breve, como la Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD)[58] o la PCL, que han demostrado altos porcentajes de sensibilidad y especificidad[59] y en el caso de esta última, se encuentra validada en Chile[46] (Tabla 7). En aquellos casos en que el puntaje obtenido por el paciente supere el punto de corte se sugiere derivar a psiquiatría para confirmación diagnóstica. Es importante recordar que estos instrumentos sólo son útiles para realizar una detección o tamizaje inicial (*screening*), y eventualmente, en el caso de la PCL, como herramienta para facilitar el seguimiento sintomático, pero el diagnóstico final siempre debe ser confirmado a través de una entrevista clínica formal por un clínico experimentado.

Consideraciones en niños y adolescentes

Los niños tienden a recuperarse en forma espontánea luego de un trauma al igual que los adultos, y si desarrollan un TEPT las alternativas de tratamiento son las mismas, aunque poniendo especial énfasis a incorporar a los padres en el tratamiento y ajustar el trabajo al nivel de desarrollo del paciente y su familia[60–62]. Es importante considerar en este grupo etario algunas manifestaciones especiales del TEPT que no suelen observarse en adultos: conductas regresivas como pérdida de control de esfínteres y del lenguaje, rechazo a separarse del cuidador y juegos estereotipados relacionados con el trauma[63].

Tabla 6. Viñeta clínica

La señora M. es una mujer de 47 años, separada, con dos hijos de 13 y 17 años. Trabaja como modista en su casa. Tuvo un episodio depresivo autolimitado en su juventud. Acude al consultorio derivada desde la urgencia para control luego de haber sido evaluada allí por dolor precordial intermitente, sin hallazgos positivos al electrocardiograma ni en la evaluación de enzimas cardíacas. Durante la entrevista con su médico, la Sra. M. relata que hace dos meses presenta un dolor opresivo retroesternal especialmente en las noches o cuando está sola, acompañado de cefalea, náuseas y temblor. Su sueño ha estado más interrumpido y hay días en los que siente permanentemente un nudo en la garganta. Indagando con mayor profundidad en sus antecedentes, aparece tangencialmente en la historia un hecho donde la paciente sufrió un grave accidente de tránsito hace cuatro meses, en el que falleció el ocupante del otro vehículo involucrado y ella resultó policontusa. Al contar su experiencia la Sra. M se muestra visiblemente afectada, comienza a temblar y se le humedecen los ojos. Ante el relato, el clínico evita seguir hablando del asunto y sigue adelante con el examen físico

Conclusiones

Un alto porcentaje de los pacientes que consultan en APS han sido afectados por experiencias traumáticas, y un grupo significativo presenta secuelas emocionales. Lamentablemente estas no suelen diagnosticarse y menos aún tratarse, producto de la variedad de síntomas que conllevan y la escasez de tiempo y disposición de clínicos y pacientes para hablar del tema.

La mayoría de las personas reacciona con un importante malestar durante los primeros días a semanas después de un trauma, el que habitualmente remite al cabo de algunas semanas. En una minoría, sin embargo, los síntomas pueden mantenerse en el tiempo y cronificarse, con altos costos para el individuo, su familia y la sociedad. Lamentablemente aún no sabemos cómo discriminar qué pacientes serán los que queden con secuelas, por lo que en las primeras dos semanas post-trauma sólo deberían brindarse intervenciones inespecíficas como los Primeros Auxilios Psicológicos. Deben evitarse las benzodiazepinas porque en el largo plazo podrían aumentar la incidencia de TEPT.

Deben sospecharse secuelas emocionales de experiencias traumáticas en toda persona con inestabilidad anímica, refractariedad a tratamientos convencionales, somatización, autoagresiones,

Tabla 7. Recursos útiles sobre trauma psicológico disponibles en internet

Para profesionales	PTSD Checklist (PCL): Características y descarga del instrumento, *National Center for PTSD* (EE.UU., en inglés), disponible en http://goo.gl/Kg81aZ Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD): Características y descarga del instrumento, *National Center for PTSD* (EE.UU., en inglés), disponible en http://goo.gl/BTBrr9 Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Traumático (portal web, en inglés), disponible en https://www.istss.org/ Sociedad Europea para el Estudio del Estrés Traumático (portal web, en inglés), disponible en https://www.estss.org/ Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación (portal web, en inglés), disponible en http://www.isst-d.org/ Centro Nacional de Trastorno de Estrés Postraumático (EE.UU.) (portal web, en inglés), disponible en http://www.ptsd.va.gov/ Eliminar la violencia contra los niños y niñas: Seis estrategias para la acción, de UNICEF, disponible en http://goo.gl/Ngxwam Abuso sexual infantil: Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia, de UNICEF, disponible en http://goo.gl/mkXnkL Preguntas más frecuentes sobre trauma y disociación para estudiantes y profesionales en formación, de *International Society for the Study of Trauma and Dissociation*, disponible en http://goo.gl/QlHbzl Revista Iberoamericana de Psicotraumatología y Disociación, disponible en http://revibapst.com/home/ Recursos gratis (en inglés): Conjunto de vídeos y presentaciones sobre distintos tópicos de estrés traumático, de *International Society for Traumatic Stress Studies*, disponible en http://goo.gl/18fLKT Primeros Auxilios Psicológicos: Guía de operaciones prácticas, 2ª edición, de National Child Traumatic Stress Network y National Center for PTSD (EE.UU.), disponible en http://goo.gl/CUJJqq Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo, de la Organización Mundial de la Salud, *War Trauma Foundation* y Visión Mundial Internacional, disponible en http://goo.gl/My3iUG Guías clínicas para el manejo de condiciones específicamente relacionadas a estrés (en inglés), de la Organización Mundial de la Salud, disponible en http://goo.gl/W1Vw2D Guías clínicas sobre Trastorno de Estrés Postraumático en adultos y niños en el nivel primario y secundario de salud (en inglés), *The National Institute for Clinical Excellence (NICE - Reino Unido),* disponible en http://goo.gl/7H1XXL Introducción al trauma psíquico, sus secuelas y su tratamiento, Dr. Rodrigo Figueroa, Unidad de Trauma y Disociación, Escuela de Medicina UC, disponible en https://goo.gl/Tm4yaV
Para padres y cuidadores	Trinka y Juan - El día que la tierra se movió. Cuento para niños y guía para padres de familia afectadas por terremotos, de *National Child Traumatic Stress Network*, disponible en http://goo.gl/536d2g Los niños y el trauma, de *International Society for Traumatic Stress Studies,* disponible en http://goo.gl/Segda1 Disociación en niños y adolescentes: Preguntas más comunes formuladas por los padres, de *International Society for the Study of Trauma and Dissociation,* disponible en http://goo.gl/HgzGYl
Para adultos afectados	Cuando un amigo o alguien a quien se quiere ha sido traumatizado, de *International Society for Traumatic Stress Studies*, disponible en http://goo.gl/GQAuHL Desastres masivos, trauma y pérdida, de *International Society for Traumatic Stress Studies,* disponible en http://goo.gl/NHgIzL Relación entre los síntomas del trauma y los problemas del uso de sustancias, de *International Society for Traumatic Stress Studies,* disponible en http://goo.gl/4A5JJU Violencia en relaciones íntimas, de *International Society for Traumatic Stress Studies,* disponible en http://goo.gl/R39e5G Recuerdo del trauma sufrido durante la infancia, de *International Society for Traumatic Stress Studies,* disponible en http://goo.gl/v09zZ5

suicidalidad crónica, trastornos de la personalidad y síntomas vagos y abigarrados, así como en aquellos en los que se conozca del antecedente traumático. La confirmación se puede facilitar con instrumentos breves de tamizaje como el PC-PTSD o el PCL.

A partir de la tercera semana aquellos pacientes que persistan con síntomas que comprometan el funcionamiento deben ser derivados a PT-CT o en su defecto a psicoterapia convencional. Si además presentan depresión o si no responden a la psicoterapia se les debe indicar un ISRS y derivar a psiquiatría.

Referencias

1. American Psychological Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®). 2013.
2. World Health Organization (WHO). Post-traumatic stress disorder [Internet]. ICD-11 Beta Draft (Joint Linearization for Mortality and Morbidity Statistics). 2015 [consultado el 2015 Dec 28]. Disponible en: http://id.who.int/icd/entity/2070699808
3. Stein DJ, McLaughlin KA, Koenen KC, Atwoli L, Friedman MJ, Hill ED, et al. DSM-5 and ICD-11 definitions of posttraumatic stress disorder: investigating "narrow" and "broad" approaches. Depress Anxiety 2014; 31 (6): 494-505.
4. Zlotnick C, Johnson J, Kohn R, Vicente B, Rioseco P, Saldivia S. Epidemiology of trauma, post-traumatic stress disorder (PTSD) and co-morbid disorders in Chile. Psychol Med 2006; 36 (11): 1523-33.
5. Norris FH, Murphy AD, Baker CK, Perilla JL, Rodríguez FG, Rodríguez J de J. Epidemiology of trauma and posttraumatic stress disorder in Mexico. J Abnorm Psychol 2003; 112 (4): 646-56.
6. Perkonigg A, Kessler RC, Storz S, Wittchen HU. Traumatic events and post-traumatic stress disorder in the community: prevalence, risk factors and comorbidity. Acta Psychiatr Scand 2000; 101 (1): 46-59.
7. Creamer M, Burgess P, McFarlane AC. Post-traumatic stress disorder: findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being. Psychol Med 2001; 31 (7): 1237-47.
8. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB. Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1995; 52 (12): 1048-60.
9. Moreau C, Zisook S. Rationale for a posttraumatic stress spectrum disorder. Psychiatr Clin North Am 2002; 25 (4): 775-90.
10. Kessler RC. Posttraumatic stress disorder: the burden to the individual and to society. J Clin Psychiatry 2000; 61 Suppl 5: 4.
11. Waddington A, Ampelas J-FF, Mauriac F, Bronchard M, Zeltner L, Mallat V. Post-traumatic stress disorder (PTSD): the syndrome with multiple faces. Encephale 2003; 29 (1): 20-7.
12. Galatzer-Levy IR, Bryant RA. 636,120 Ways to Have Posttraumatic Stress Disorder. Perspect Psychol Sci 2013; 8 (6): 651-62.
13. Wade D, Howard A, Fletcher S, Cooper J, Forbes D. Early response to psychological trauma-what GPs can do. Aust Fam Physician 2013; 42 (9): 610-4.
14. Grinage BD. Diagnosis and management of post-traumatic stress disorder. Am Fam Physician 2003; 68 (12): 2401-8.
15. Stein MB, McQuaid JR, Pedrelli P, Lenox R, Mccahill ME. Posttraumatic stress disorder in the primary care medical setting. Gen Hosp Psychiatry 2000; 22 (4): 261-9.
16. Ministerio de Salud de Chile. Estudio de carga de enfermedad y carga atribuible [Internet]. Ministerio de Salud de Chile. 2008 [consultado el 28 de marzo de 2016]. Disponible en: http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/04/Informe-final-carga_Enf_2007.pdf
17. Mathers C, Fat D, Boerma J. The global burden of disease: 2004 update. 2008 [consultado el 28 de diciembre de 2015]; Disponible en: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf
18. Monson CM, Taft CT, Fredman SJ. Military-related PTSD and intimate relationships: from description to theory-driven research and intervention development. Clin Psychol Rev 2009; 29 (8): 707-14.
19. Taft CT, Watkins LE, Stafford J, Street AE, Monson CM. Posttraumatic stress disorder and intimate relationship problems: a meta-analysis. J Consult Clin Psychol 2011; 79 (1): 22-33.
20. McFarlane AC. Military deployment: the impact on children and family adjustment and the need for care. Curr Opin Psychiatry 2009; 22 (4): 369-73.
21. Sayers SL, Farrow VA, Ross J, Oslin DW. Family problems among recently returned military veterans referred for a mental health evaluation. J Clin Psychiatry 2009; 70 (2): 163-70.
22. Wilcox HC, Storr CL, Breslau N. Posttraumatic stress disorder and suicide attempts in a community sample of urban american young adults. Arch Gen Psychiatry 2009; 66 (3): 305-11.

23. Breslau N. The epidemiology of posttraumatic stress disorder: what is the extent of the problem? J Clin Psychiatry 2001; 62 Suppl 1: 16-22.
24. Ozer EJ, Best SR, Lipsey TL, Weiss DS. Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychol Bull 2003; 129 (1): 52-73.
25. Brewin CR, Andrews B, Valentine JD. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. J Consult Clin Psychol 2000; 68 (5): 748-66.
26. Bryant R, Creamer M, O'Donnell M, Silove D, McFarlane A. The capacity of acute stress disorder to predict posttraumatic psychiatric disorders. J Psychiatr Res 2012; 46 (2): 168-73.
27. Bryant RA, Creamer M, O'Donnell M, Silove D, Mcfarlane AC, Forbes D. A Comparison of the Capacity of *DSM-IV* and *DSM-5* Acute Stress Disorder Definitions to Predict Posttraumatic Stress Disorder and Related Disorders. J Clin Psychiatry 2015; 391-7.
28. Green BL, Lindy JD, Grace MC, Leonard AC. Chronic posttraumatic stress disorder and diagnostic comorbidity in a disaster sample. J Nerv Ment Dis; 1992; 180 (12): 760-6.
29. Figueroa RA, Marín H, González M. Psychological support for disaster victims: an evidence-based care model. Rev Med Chile 2010; 138 (2): 143-51.
30. Figueroa RA, Cortés PF. Propuesta para abordar los problemas de salud mental detectados en el proceso diagnóstico de la Delegación Presidencial para la reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Rev Med Chile 2016; 144: 247-52.
31. Effects of Traumatic Stress after Mass Violence, Terror, or Disaster-PTSD: National Center for PTSD. 2015 Aug 17 [consultado el 2015 Dec 28]; Disponible en: http://www.ptsd.va.gov/professional/trauma/disaster-terrorism/stress-mv-t-dhtml.asp
32. Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? Am Psychol 2004; 59 (1): 20-8.
33. Tedeschi RG, Calhoun LG. The Posttraumatic Growth Inventory: measuring the positive legacy of trauma. J Trauma Stress 1996; 9 (3): 455-71.
34. Agorastos A, Marmar CR, Otte C. Immediate and early behavioral interventions for the prevention of acute and posttraumatic stress disorder. Curr Opin Psychiatry 2011; 24 (6): 526-32.
35. Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation, World Vision Internacional. Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo. Ginebra: OMS; 2012.
36. Figueroa RA, Repetto P, Bernales M. Incorporation of psychological first aid to the undergraduate curriculum. Rev Med Chile 2014; 142 (7): 934-5.
37. Hobfoll SE, Watson P, Bell CC, Bryant RA, Brymer MJ, Friedman MJ, et al. Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: empirical evidence. Psychiatry 2007; 70 (4): 269-83.
38. Robertson K. Active listening: more than just paying attention. Aust Fam Physician 2005; 34 (12): 1053-5.
39. Foa E, Hembree E, Rothbaum BO. Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences therapist guide. Oxford University Press; 2007.
40. Reger GM, Hoffman J, Riggs D, Rothbaum BO, Ruzek J, Holloway KM, et al. The "PE coach" smartphone application: An innovative approach to improving implementation, fidelity, and homework adherence during prolonged exposure. Psychol Serv 2013; 10 (3): 342-9.
41. Jacobson R. Pocket Therapy. Sci Am Mind. Scientific American, Inc. 2014; 25 (6): 72-3.
42. Progressive Relaxation: A Physiological and Clinical Investigation of Muscular States and Their Significance in Psychology and Medical Practice. J Am Med Assoc. American Medical Association 1938; 111 (12): 1129.
43. Blanaru M, Bloch B, Vadas L, Arnon Z, Ziv N, Kremer I, et al. The effects of music relaxation and muscle relaxation techniques on sleep quality and emotional measures among individuals with posttraumatic stress disorder. Ment Illn 2012; 4 (2): e13.
44. Guina J, Rossetter S. Benzodiazepines for PTSD: a systematic review and meta-analysis. J Psychiatr 2015; 21 (4): 281-303.
45. Barbui C, Gastaldon C, Cipriani A. Benzodiazepines and risk of dementia: true association or reverse causation? Epidemiol Psychiatr Sci 2013; 22 (4): 307-8.
46. Vera-Villarroel P, Zych I, Celis-Atenas K, Córdova-Rubio N, Buela-Casal G. Chilean validation of the Posttraumatic Stress Disorder Checklist-Civilian version (PCL-C) after the earthquake on February 27, 2010. Psychol Rep 2011; 109 (1): 47-58.
47. Sanz J, Vázquez C. Fiabilidad, validez y datos normativos del inventario para la depresión de Beck. Psicothema 1998; 10 (2): 303-18.
48. Bisson JI, Roberts NP, Andrew M, Cooper R, Lewis C. Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults. Cochrane database Syst Rev 2013; 12: CD003388.
49. Difede J, Olden M, Cukor J. Evidence-based treatment of post-traumatic stress disorder. Annu Rev Med Annual Reviews 2014; 65: 319-32.
50. Gartlehner G, Forneris CA, Brownley KA, Gaynes BN,

Sonis J, Coker-Schwimmer E, et al. Interventions for the Prevention of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults After Exposure to Psychological Trauma. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2013.
51. Cognitive Processing Therapy for Post-Traumatic Stress Disorder. Society of Clinical Psychology [Internet]. [consultado el 2015 Dec 28]. Disponible en: https://www.div12.org/psychological-treatments/disorders/post-traumatic-stress-disorder/cognitive-processing-therapy/
52. Shapiro F. Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols, and procedures. The Guilford Press; 2001.
53. Lee CW, Cuijpers P. A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories. J Behav Ther Exp Psychiatry 2013; 44 (2): 231-9.
54. Terapeutas. EMDR Chile [Internet] [consultado el 28 de diciembre de 2015]. Disponible en: http://www.emdrchile.cl/terapeutas/
55. McFarlane AC. The long-term costs of traumatic stress: intertwined physical and psychological consequences. World Psychiatry 2010; 9 (1): 3-10.
56. Glaesmer H, Brähler E, Gündel H, Riedel-Heller SG. The association of traumatic experiences and posttraumatic stress disorder with physical morbidity in old age: a German population-based study. Psychosom Med 2011; 73 (5): 401-6.
57. Harned MS, Rizvi SL, Linehan MM. Impact of co-occurring posttraumatic stress disorder on suicidal women with borderline personality disorder. Am J Psychiatry 2010; 167 (10): 1210-7.
58. Prins A, Ouimette P, Kimerling R, Camerond RP, Hugelshofer DS, Shaw-Hegwer J, et al. The primary care PTSD screen (PC-PTSD): development and operating characteristics. Prim Care Psychiatry 2004; 9 (1): 9-14.
59. Spoont MR, Williams JW, Kehle-Forbes S, Nieuwsma JA, Mann-Wrobel MC, Gross R. Does This Patient Have Posttraumatic Stress Disorder?: Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA 2015; 314 (5): 501-10.
60. Silverman WK, Ortiz CD, Viswesvaran C, Burns BJ, Kolko DJ, Putnam FW, et al. Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents exposed to traumatic events. J Clin Child Adolesc Psychol 2008; 37 (1): 156-83.
61. Taylor TL, Chemtob CM. Efficacy of treatment for child and adolescent traumatic stress. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158 (8): 786-91.
62. Gillies D, Taylor F, Gray C, O'Brien L, D'Abrew N. Psychological therapies for the treatment of post-traumatic stress disorder in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12: CD006726.
63. PTSD in Children and Teens-PTSD: National Center for PTSD. 2015 Aug 13 [consultado el 28 de diciembre de 2015]; Disponible en: http://www.ptsd.va.gov/public/family/ptsd-children-adolescents.asp
64. Spiegel D, Loewenstein RJ, Lewis-Fernández R, Sar V, Simeon D, Vermetten E, et al. Dissociative disorders in DSM-5. Depress Anxiety 2011; 28 (12): E17-45.
65. Common Reactions After Trauma-PTSD: National Center for PTSD. 2015 Aug 13 [consultado el 28 de diciembre de 2015]; Disponible en: http://www.ptsd.va.gov/public/problems/common-reactions-after-trauma.asp

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V. (2016) *Trauma psicológico en la atención primaria: orientaciones de manejo.* Revista Médica de Chile 2016; 144, 643-655. Chile.[1]

[1] Uso con fin académico.

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Manual “ABCDE”

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

CIGIDEN
Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Medicina, Departamento de Psiquiatría
Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN)

Manual ABCDE para la aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos

En crisis individuales y colectivas.

Paula Cortés Montenegro
Rodrigo Figueroa Cabello

1ª Edición

Índice

Presentación 4

Antecedentes 6

Protocolo ABCDE 8

escucha Activa 12

reentrenamiento de la (B)entilación 15

Categorización de necesidades 19

Derivación a redes de apoyo 21

psicoEducación 23

Cuadro Resumen 28

Bibliografía 30

Recursos en Línea 36

Glosario y Términos 40

Servicios y Redes de Apoyo 44

¿Qué puedo hacer frente a una crisis? 50

Presentación

Este manual fue diseñado en el contexto del estudio *"Primeros Auxilios Psicológicos: Ensayo Clínico Randomizado de adultos afectados por un trauma no intencional en una sala de emergencias"*, financiado por el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) Chile, Programa FONDAP 15110017/2011.

www.cigiden.cl

Este documento ha sido creado por:
Paula Cortés Montenegro,
Psicóloga, Coordinadora de investigación.

Rodrigo Figueroa Cabello,
Médico Psiquiatra, Investigador responsable.

Agradecimientos

A los psicólogos Humberto Marín Uribe, Ph.D., Nadia Egas Tapia, M.Sc., y Katitza Marinkovic Chávez, M.Sc., miembros del equipo Kokoronokea (CIGIDEN) por prestar apoyo a la elaboración de este *manual*. Este material constituirá un aporte para la implementación del *"Modelo de protección de la salud mental en la gestión del riesgo de emergencias y desastres"* en desarrollo, patrocinado por un proyecto de cooperación internacional entre Japón y Chile.

A la Fundación Científica y Tecnológica de la Asociación Chilena de Seguridad (FUCYT), a través del concurso coordinado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por brindar apoyo económico para la creación de este material y la investigación de los Primeros Auxilios Psicológicos.

Antecedentes

Existe una falta de consenso teórico y empírico respecto de cuál es la intervención temprana más efectiva y segura para restablecer el bienestar emocional y la funcionalidad de una persona recientemente afectada por una situación potencialmente traumática, así como para prevenir el desarrollo de secuelas emocionales de largo plazo. Múltiples organizaciones internacionales promueven el uso de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), a pesar de no existir evidencia concluyente que respalde esta recomendación (Dieltjens, Moonens, Van Praet, De Buck, Vekerckhove, 2014; Bisson y Lewis, 2009; Fox, Burkle, Bass, Pia, Epstein, Markenson, 2012).

Los PAP están definidos como una técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en situación de crisis (ej. crisis humanitarias, accidente de tránsito, noticia de familiar gravemente enfermo, incendio, desastre natural, asalto, etc.), que tiene como objetivo recuperar el equilibrio emocional y prevenir el desarrollo de secuelas psicológicas.

Los orígenes de los PAP se remontan a mediados 2000, con los estudios de Hobfoll y cols. (2007), quienes plantearon cinco elementos principales para la intervención inmediata de una crisis: calma, seguridad, autoeficacia, conexión y esperanza. Como se trata de una intervención de naturaleza de asistencia social, y no psicológica, requiere asegurar la satisfacción de necesidades básicas, como agua, alimento, techo, abrigo, seguridad, información y apoyo de personas cercanas, entre otras. Todas estas intervenciones tendrían la capacidad de generar un efecto psicológico que mitiga el estrés y la angustia, ayudando al afectado a restablecer el equilibrio biopsicosocial y minimizando el potencial de desarrollar un trauma psicológico, lo que es coherente con la Teoría de Conservación de Recursos (Hobfoll 1989).

Los PAP buscan ofrecer ayuda de manera práctica y no invasiva centrándose en las necesidades y preocupaciones inmediatas de las personas y atenderlas en la medida de lo posible; escuchar al afectado sin sobreestimular a hablar sobre el tema; reconfortar a las personas y ayudar a la calma con técnicas de relajación; y psicoeducar, entre otras actividades. Parte importante de esta técnica es estar disponible para aquellos que necesiten apoyo y ayuda, de ninguna manera forzando u obligando a aquellos que no la necesitan o que se hayan negado a recibirla (OMS, 2012).

A pesar de contar con un marco teórico consistente, su efecto benéfico no está demostrado por evidencia empírica. Dada esta

Como debe ser utilizada esta versión

situación, en 2015 un equipo de CIGIDEN y del Departamento de Psiquiatría UC implementó un estudio, cuyo objetivo fue determinar la efectividad y seguridad de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) como herramienta de prevención secundaria del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y otros síntomas en población afectada por un trauma no intencional reciente.

Al alero de este estudio surgió la primera versión del presente *manual*, el cual fue utilizado por los reclutadores en los distintos servicios de urgencia de cinco hospitales públicos y privados de la ciudad de Santiago de Chile. En ese contexto, el objetivo del *manual* fue orientar el trabajo de campo de los reclutadores, de manera de facilitar la aplicación del protocolo de estudio y de los PAP.

En este estudio, los pacientes que recibieron PAP se recuperaron más rápido que los que recibieron una intervención de psicoeducación, desarrollando menos síntomas de reexperimentación como pesadillas, recuerdos, sensaciones físicas, o flashbacks durante el primer mes luego de la experiencia traumática.

Además, reportaron un mayor bienestar subjetivoluego de la intervención.

La presente versión es una edición adaptada del protocolo del estudio. Este *manual* está diseñado para ser utilizado por cualquier persona que participe como apoyo asistencial a la crisis, sin ser necesariamente profesional de la salud mental (psicólogo o psiquiatra). Es relevante señalar que contar con este *manual* no reemplaza la capacitación y entrenamiento indispensables en quienes deseen intervenir con esta técnica.

El principal objetivo de este *manual* es guiar la aplicación de los PAP en diversos contextos de crisis.

A continuación, usted encontrará una serie de términos relacionados a la crisis y al trauma psíquico que pueden serle de utilidad. Luego, se expone la etapa preparatoria a la implementación de la técnica, seguido del PAP paso a paso. Esta guía es de índole práctica, por lo que se encontrará con diversas frases útiles que pueden ayudarlo al momento de estar apoyando a la persona en crisis. Finalmente, se pone a disposición una serie de recursos últiles para la aplicación de los PAP, entre los que se encuentran enlaces de interés en la web que buscan complementar la tarea hacia la comprensión del trauma psíquico, ejemplos de folletería para ser entregada a los afectados que reciban los PAP, así como ofrecer material multimedia de calidad e información sobre centros de apoyo.

Protocolo ABCDE de Primeros Auxilios Psicológicos

A

escucha
Activa

B

reentrenamiento
de la (B)entilación

C

Categorización
de necesidades

D

Deivación a
redes de apoyo

E

psico-
Educación

Los objetivos de los PAP son:

1. Brindar alivio emocional inmediato.
2. Facilitar la adaptación.
3. Prevenir el desarrollo de psicopatología.

Vea vídeo explicativo en:
is.gd/primerosauxiliospsicologicos

Etapa de Preparación

Antes de aplicar los PAP, es necesario darse unos minutos para prepararse y chequear una serie de antecedentes que pueden serle de utilidad:

1. Entrenamiento: Lo primero es contar con un entrenamiento adecuado en PAP. En la sección "*Recursos en línea*" podrá encontrar lugares donde se realiza un entrenamiento certificado.

2. Coordinación con su equipo (u otros): Es recomendable establecer un equipo de trabajo, sobre todo si se encuentra en una situación (laboral o voluntaria) en la que las experiencias traumáticas son frecuentes. Antes de intervenir, procure coordinarse con los otros organismos que están participando en la respuesta a la emergencia o situación de crisis. Una intervención que no se encuentra bien articulada con el resto del sistema de respuesta es altamente probable que sea inefectiva.

3. ¿Estoy en condiciones?: Es necesaria una auto-evaluación de la condición personal frente a la crisis. Si se encuentra afectado por alguna situación personal (ej. duelo, crisis familiar, experiencia traumática reciente), es recomendable no efectuar la intervención a un tercero. De esta manera, evitará consecuencias negativas sobre sí mismo y sobre la persona afectada.

4. Infórmese sobre la situación: Si ha decidido intervenir en PAP, es muy importante que anticipadamente recabe la mayor cantidad de información sobre la situación desde fuentes confiables. Es recomendable llegar bien preparados, con un amplio conocimiento acerca de los recursos disponibles en el lugar de la emergencia, de ese modo podrá entregar una mejor orientación al afectado. Estar informado reducirá su ansiedad y lo ayudará a tomar mejores decisiones junto al afectado.

5. Evalúe aplicabilidad: No todas las personas que experimentan una crisis van a necesitar PAP. Es muy importante respetar las decisiones y recursos personales del afectado, así como comunicar que usted estará disponible para ofrecer ayuda si la necesita más adelante. No olvide observar si la persona se encuentra en una situación de emergencia psiquiátrica, pues en ese caso, la aplicación y los resultados de este protocolo pueden ser ineficaces (ver página 31).

6. Identifíquese: Es fundamental compartir con el afectado su nombre, su institución y las razones de su presencia en ese lugar. Esto creará un ambiente de seguridad para la persona, facilitando la aplicación de los PAP. Es indispensable portar alguna credencial que lo identifique y que señale la organización a la que pertenece. Así como es necesaria su presentación, también lo es conocer el nombre y datos generales acerca del afectado en el lugar de la emergencia o desastre (ej. quién es, qué estaba haciendo allí, quién lo acompaña, etc.).

Recomendamos seguir los siguientes pasos en orden, evitando siempre forzar la persona afectada a aceptar cada una de las actividades. En este sentido, cada paso constituye una oferta, no una obligación. Adicionalmente, y de acuerdo a las necesidades particulares de cada beneficiario, es posible saltarse pasos o invertirlos.

A continuación, se presenta el protocolo organizado en 5 letras *"ABCDE"*, que sirven como ayuda memoria de cada uno de los pasos del protocolo.

A
escucha Activa

B
reentrenamiento de la (B)entilación

C
Categorización de necesidades

D
Deivación a redes de apoyo

E
psico-Educación

Vea vídeo demostrativo en:
is.gd/escuchaactiva

A
escucha Activa

Este paso puede tomar entre 10 a 20 minutos. Saber comunicarse con una persona angustiada, ansiosa o alterada es fundamental. **En este estado, la persona puede querer o no contarle su historia.** Escuchar ese testimonio puede ser de gran ayuda para calmar a la persona afectada, por lo cual es esencial dar espacio para que ella cuente de manera espontánea lo que le está ocurriendo, **pero sin presionarlo.** Para otras personas guardar silencio será preferible: permanecer a su lado, en silencio, puede ser de gran ayuda. Lo central de la escucha activa es ser capaz de transmitirle a la otra persona que allí hay un ser humano que está *comprendiendo* lo que le pasa.

Cuídese del *furor curandis*, un impulso irreflexivo por *"hacer algo"* por quien está sufriendo. Esta condición podría hacerlo decir o hacer cosas que dañen a la persona aunque no haya sido su intención.

El lenguaje corporal es una herramienta fundamental para transmitir *comprensión* y *empatía*. Utilizar las posturas, los gestos y el contacto visual son parte esencial de esta técnica. Guíe la escucha activa con la siguiente tabla:

LO QUE DEBE HACER O DECIR	LO QUE NO DEBE HACER O DECIR
Hágale entender al afectado que está escuchándolo. Resuma las causas del sentimiento utilizando el estilo del relato y considerando las palabras referidas por el afectado **(parafrasear).** Asienta con la cabeza o diga: *"mmm...claro, sí"* otra alternativa: *"entonces usted me dijo que..."*	· No se distraiga. · No mire el reloj ni mire insistentemente hacia otro lado. · No se apresure a dar una solución si la persona quiere ser escuchada.
Tenga paciencia con el relato, sin preguntar por detalles que la persona no ha referido. Tolere los espacios de silencio, la pena o el llanto. No se precipite a decir algo inapropiado *"por hacer algo"*. Controle el *furor curandis*.	No juzgue lo que la persona hizo o no hizo, sintió o no sintió: *"usted no debió haber hecho eso..."* *"no debería sentirse así..."*
Si es señalado, pregunte por la situación de otras personas si es el caso. Por ejemplo, *"¿y se encuentra bien su hija?"*	No cuente la historia de otra persona o la suya propia.

LO QUE DEBE HACER O DECIR

Permanezca cerca a la persona, sentado a su lado y mirando al rostro. Sólo toque a la persona en actitud de apoyo si está confiado de que será bien recibido por ésta. Puede preguntarle si le incomoda.

Utilice **técnica reflejo**, adoptando posturalmente una actitud similar a la del afectado, que le comunique que usted está en la misma *"sintonía afectiva"*. Hágale saber que comprende su sufrimiento y que entiende que se puede estar sintiendo muy mal, sin ser autoreferente.

"Esto debe ser difícil para usted..."

LO QUE NO DEBE HACER O DECIR

No toque a la persona si no está seguro de que sea bien recibido.

No minimice ni dé falsas esperanzas:

"puedo asegurarle que usted va salir adelante"

"afortunadamente no fue para tanto"

"ahora tiene un angelito que la cuida"

"no te preocupes... eres joven, y ya vas a ver que vas a encontrar pareja pronto"

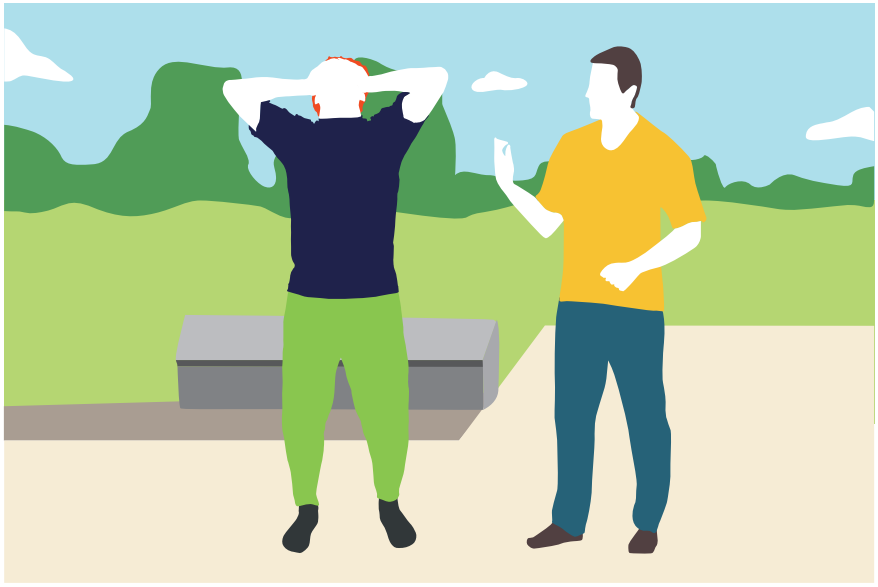
"Dios sabe por qué hace las cosas"

"no hay mal que por bien no venga"

"todo pasa por algo"

Si la persona está muy angustiada, ayúdele a calmarse. Ofrezca un vaso de agua si es posible o avance al siguiente paso reentrenamiento de la (B)entilación.

Vea vídeo demostrativo en:
is.gd/bentilacion



B
reentrenamiento de la (B)entilación

Algunas personas que han vivido una crisis pueden mostrarse ansiosas o alteradas, sintiendo confusión o encontrándose sobrepasadas por la situación, observándose temblorosas, teniendo dificultades para respirar o sintiendo su corazón muy agitado. Por esta razón, los PAP contemplan unos minutos para enseñar y practicar reentrenamiento de la (B)entilación y así ayudar a las personas a tranquilizarse. Este paso toma *10 minutos*, aunque habrá personas que necesitarán más tiempo. Recuerde que este y otros pasos pueden aplicarse ***siempre y cuando la persona quiera recibirlo.***

Explique que la forma como respiramos influye en nuestras emociones, y que es por eso que en el yoga y la meditación se trabaja con la respiración.

Técnicas de respiración:

1.-Diríjase a la persona y dígale

"Ahora ensayaremos el re-entrenamiento de la respiración: consiste en inspirar, exhalar y luego esperar un momento con los pulmones vacíos hasta volver a inspirar... lo importante es la pausa luego de vaciar los pulmones"

2.-Puede pedirle que lo practiquen juntos.

3.-Para empezar, pídale a la persona que adopte una postura relajada y cómoda, poniendo los pies en el piso y sintiendo ese contacto.

"Si lo desea y se siente cómodo, puede cerrar los ojos o mirar un punto fijo con la mirada baja. Ahora vamos a intentarlo..."

1

INSPIRACIÓN
4 tiempos.

2

EXHALACIÓN: POR LA NARIZ O POR LA BOCA.
4 tiempos.

3

RETENCIÓN CON LOS PULMONES *"VACÍOS".*
4 tiempos.

Los ***4 tiempos*** no siguen necesariamente el tiempo real (*en segundos*). La duración de los tiempos es variable, según el estado de agitación de la persona. Acomode la duración de los tiempos para que el afectado se sienta cómodo y no se quede sin aire.

"Para ayudarse, puede repetir mentalmente y de forma lenta la palabra calma o tranquilo cada vez que bote el aire o puede imaginar que la tensión se escapa con el aire que bota. Intentémoslo de nuevo...".

Una vez que el afectado haya comprendido la mecánica puede dejar que continúe solo por 10 minutos, reforzando lo bien que lo está haciendo:

"muy bien...
está haciéndolo excelente".

Adicionalmente, también puede guiarse utilizando las pautas adaptadas de Foa, Hembree y Rothbaum (2007) para el reentrenamiento de la respiración, que siguen la misma lógica anteriormente expuesta:

· Explique detalladamente la lógica del ejercicio:

> *"La forma como respiramos modifica nuestras emociones. Cuando botamos el aire nos relajamos más que cuando inspiramos (al contrario de lo que se suele creer), por lo que podemos entrar en un estado de calma si prolongamos el tiempo en que nuestros pulmones están vacíos..."*.

· Explique y demuestre la mecánica del ejercicio:

> *"El ejercicio se trata de que usted inspire en cuatro tiempos, exhale en cuatro tiempos y aguante cuatro tiempos más antes de volver a inspirar". Ahora mire como yo lo hago... [hágalo usted mismo].*

· Acompañe a hacer el ejercicio:

> *"Ahora lo hará usted, y yo lo acompañaré recordándole cómo debe hacerlo. Inspire... dos, tres, cuatro... exhale, dos, tres cuatro... aguante, dos tres, cuatro..." [repita el ciclo por uno o dos minutos acompañando al afectado]. "Mientras exhala puede pensar en la palabra calma".*

· Indíquele al afectado que lo haga diariamente por diez minutos, tres veces al día (mañana, tarde y noche) y cada vez que se sienta angustiado. Puede ayudarse con las aplicaciones Breath Pacer o Paced Breathing disponible para teléfonos inteligentes:

> *"Le voy a pedir que realice este ejercicio durante 10 minutos todos los días en la mañana al despertar, después de almuerzo, antes de irse a dormir y cada vez que sienta que está comenzando a angustiarse mucho. Mientras más use esta técnica, más fácil será la próxima vez que la use".* Usted puede ayudarse con algunas aplicaciones disponibles gratuitamente para celulares, como una llamada *Breath Pacer* y otra llamada *Paced Breathing*.

Vea vídeo demostrativo en:
is.gd/categorizacion

C

Categorización de necesidades

Luego de un evento traumático es común que se produzca confusión mental y las personas tengan dificultades para ordenar los diferentes pasos que deben seguir para solucionar sus problemas (ej. denuncia de siniestro, llamada a familiares, búsqueda de pertenencias, trámites legales, etc.). Usted puede ayudar mucho a la persona acompañándola en el proceso de jerarquización de sus necesidades, para luego ayudarla a contactar los servicios de salud y seguridad social que podrán serle de ayuda. Recuerde que esta es una intervención breve, y su trabajo se centra en ayudar a identificar las necesidades y jerarquizarlas. Es importante que la persona utilice sus propios recursos o los de sus redes de apoyo personales o comunitarias para hacer frente a la crisis que está viviendo, de manera que lo logrado se mantenga luego de que usted termine su trabajo.

LO QUE DEBE HACER O DECIR	LO QUE NO DEBE HACER O DECIR
Escuche el relato e identifique las preocupaciones del afectado: *"¿Qué es lo que le preocupa o necesita ahora? ¿puedo ayudarlo(a) a resolverlo?"*	Decidir cuáles son sus necesidades, sin prestar atención al relato del afectado. *"Antes que me diga nada, yo creo que lo más importante que usted debe hacer es..."*
Ayude a las personas a priorizar sus necesidades: Se les puede pedir que distingan entre lo que necesitan solucionar inmediatamente y lo que puede esperar: *"... me doy cuenta de que son muchas las cosas que le preocupan. ¿Le parece si vamos paso a paso y nos enfocamos primero en lo más urgente?"*	Resolver las necesidades a medida que el afectado las va mencionando, sin organizar ni jerarquizar.

Ud. puede intentar también con las siguientes frases (disponibles en Figueroa, Cortés, Accatino y Sorensen, 2016):

- *"¿Cuál cree que es el problema más importante de resolver primero?"*
- *"¿Qué cosas le han ayudado en el pasado cuando ha tenido que lidiar con tanto estrés?"*
- *"Obviamente son muchos problemas juntos que sería bueno ordenar para ir uno por uno... si quiere puedo ayudarle a hacerlo".*
- *"Entiendo que se sienta sobrepasado. Veamos si podemos identificar al menos tres cosas sobre las que tiene actualmente control para focalizarnos en ellas".*

Vea vídeo demostrativo en:
is.gd/derivacionaredes

D

Deivación a redes de apoyo

Una vez identificadas estas necesidades, ayude a la persona a contactar a las personas y/o servicios de apoyo social que podrán ayudarle a satisfacer dichas necesidades ahora y más adelante, junto al material *Servicios y Redes de Apoyo* (ver Anexo).

Recuerde siempre que la primera red de apoyo es la familia y los amigos. Para este paso es indispensable que antes de contactar al afectado haya estudiado bien la oferta de servicios de apoyo social disponibles en el lugar donde proveerá los PAP.

LO QUE DEBE HACER O DECIR

Facilite el contacto con sus familiares, amigos y/o trabajo. Sugiera llamarlos si es necesario (identifique teléfonos públicos disponibles o gestione un teléfono móvil con su institución).

Haga sugerencias prácticas sobre cómo recibir la ayuda necesitada. Utilice la información de contacto disponible en el material *Servicios y Redes de Apoyo.*

LO QUE NO DEBE HACER O DECIR

Tomar la iniciativa *"ayudar"* a la persona con asuntos que él mismo puede hacer.

"Voy a ir con la asistente social para preguntarle sobre la situación de su madre"

"Páseme el celular, yo llamaré a su hijo para contarle lo que pasó"

Puede ayudarse con las siguientes frases útiles (disponibles en Figueroa, Cortés, Accatino y Sorensen, 2016):

- *"¿Su familia sabe lo que sucedió y que usted está aquí?"*
- *"Se ha visto que ayuda mucho para estar mejor compartir con amigos y familiares... pasar tiempo juntos, acompañados, ¿existirá algún momento en la semana en el que pueda dedicarse regularmente a compartir con su familia y amigos?"*
- *"Entiendo que quizás usted desconfíe de los servicios públicos de apoyo, pero si más adelante cambia de opinión, quisiera que sepa cómo contactarlos"*
- *"No tengo información sobre la situación de sus hijos, pero veamos si podemos averiguar algo sobre ellos en las páginas de búsqueda de personas o con la policía..."*
- *"Si le surge alguna duda más adelante, puede venir a preguntarme, o quizás se anime a llamar al teléfono gratuito Salud Responde (600 360 7777), donde alguien podrá orientarle las 24 horas del día, los siete días de la semana"*

Vea vídeo demostrativo en:
is.gd/psicoeducacion

E

psico-Educación

Para finalizar, promueva estrategias de respuesta positivas ante el estrés, explicando y entregando una copia del material, *¿Qué puedo esperar frente a una crisis?* (ver Anexo). Revise el material con el afectado, y resuelva sus dudas.

Puede ayudarse con la siguiente tabla, la cual es de utilidad para conocer las reacciones normales frente al estrés o a experiencias traumáticas recientes.

Es muy importante que usted normalice aquellas reacciones emocionales que –aunque por cierto incómodas– son normales en situaciones de crisis, como labilidad emocional, dificultad para pensar, insomnio, angustia, entre otras. De esta manera la persona no interpretará lo que le ocurre como una señal de estar *"perdiendo la cabeza"*. Enfatícele que lo más probable es que el malestar que siente se vaya pasando sin necesidad de ayuda en algunas semanas, muéstrele cómo ayudarte a sí mismo y a sus conocidos, cuáles son las señales de alarma, y qué hacer si aparecen.

Tabla 1. Reacciones emocionales, cognitivas, físicas e interpersonales comunes frente a experiencias traumáticas recientes.

Reacciones emocionales

- Estado de shock
- Terror
- Irritabilidad
- Sentimiento de culpa (hacia sí mismo y hacia otros)
- Rabia
- Dolor o tristeza
- Embotamiento emocional
- Sentimientos de impotencia
- Pérdida del disfrute derivado de actividades familiares
- Dificultad para sentir alegría
- Dificultad para experimentar sentimientos de amor y cariño por otros

Reacciones físicas

- Fatiga, cansancio
- Insomnio
- Taquicardia o palpitaciones
- Sobresaltos
- Exaltación
- Incremento de dolores físicos
- Reducción de la respuesta inmune
- Dolores de cabeza
- Perturbaciones gastrointestinales
- Reducción del apetito
- Reducción del deseo sexual
- Vulnerabilidad a la enfermedad

Continuación: Tabla 1.

Reacciones cognitivas

- Dificultades para concentrarse
- Dificultades para tomar decisiones
- Dificultades de memoria
- Incredulidad
- Confusión
- Pesadillas
- Autoestima decaída
- Noción de autoeficacia disminuida
- Pensamientos culposos
- Pensamientos o recuerdos intrusivos sobre el trauma
- Preocupación
- Disociación (ej. visión túnel, estado crepuscular de conciencia, sensación de irrealidad, dificultades para recordar, sensación de separación del cuerpo, etc.)

Reacciones interpersonales

- Incremento en conflictos interpersonales
- Retraimiento social
- Reducción en las relaciones íntimas
- Alienación
- Dificultades en el desempeño laboral o escolar
- Reducción de la satisfacción
- Desconfianza
- Externalización de la culpa
- Externalización de la vulnerabilidad
- Sensación de abandono o rechazo
- Sobreprotección

Adaptado de Common Reactions After Trauma (2015), del National Center for PTSD, U.S Department of Veterans Affairs.

Al momento de utilizar el material gráfico (ver Anexos), puede utilizar las siguientes frases para orientar la psicoeducación:

- *"Todas esas sensaciones que está experimentando son muy comunes después de una experiencia así. La mayoría de las personas que han vivido una situación tan estresante las presentan por días e incluso semanas, pero luego se van yendo. No significan que esté perdiendo la cabeza o que sea débil..."*.
- *"Preocuparse de usted, y pasar un tiempo de relajo junto a su familia puede ser muy útil durante estos días difíciles"*.
- *"Afortunadamente los seres humanos solemos salir adelante de este tipo de situaciones, por más duras que parezcan, por lo que tengo confianza en que usted podrá superar todo esto..."*.
- *"Iremos controlando su evolución en las próximas semanas. Normalmente este malestar va disminuyendo con los días y semanas, por lo que tengo confianza en que todo esto irá pasando poco a poco"*.
- *"Lo felicito... todo eso que ha hecho le ayudará a salir adelante. Me alegro de ver como va tomando decisiones y saliendo adelante"*.
- *"Durante estas dos primeras semanas evite pasar pegado a la tele viendo noticias sobre el terremoto... y evite que sus niños hagan lo mismo"*.
- *"Estar más emotivo, quizás con un poco de insomnio, no poder parar de pensar en lo que pasó, más temeroso, más irritable, por momentos más retraído... todo eso es normal. Preocúpese si con los días eso no va pasando o si aparecen ganas de morir, hacerle daño a otros, si aparecen crisis de pánico repetidas, si ve que algún conocido suyo pierde contacto con la realidad... en esos casos venga o tráigalo inmediatamente"*.
- *"Durante estos días pueden darle más ganas de beber alcohol, fumar o quizás usar otra droga... Evítelo y reemplácelo por deporte, algún hobbie, yoga o meditación, que se ha visto son más efectivos para superar momentos difíciles"*.

Es relevante señalar que si en cualquier momento de la intervención, el afectado evidencia alguno de estos criterios, será necesario derivar a urgencia psiquiátrica:

- Ideación suicida
- Agresividad hacia sí mismo y terceros
- Catatonia (alteración en el control sobre los movimientos voluntarios)
- Psicosis (pérdida del juicio de realidad)
- Trastorno psiquiátrico previo grave en riesgo de descompensación severa producto del trauma (ej. esquizofrenia, trastorno bipolar, dependencia de sustancias).

Para el proveedor

Permanecer en constante auto-observación con el fin de identificar signos de burnout, un síndrome que aparece como señal de estar sobrepasado y exhausto por el trabajo.

Procurar realizar actividades de autocuidado, a nivel individual y como de equipo. Los PAP usted también puede usarlos consigo mismo o con sus compañeros.

Cuadro resumen

Para facilitar la aplicación de esta técnica, a continuación se presenta el protocolo de actividades paso a paso.

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)

A

escucha Activa

Ofrezca escucha activa y escuche por *10-20 min* según necesidad. Utilice la siguiente frase para invitar a comenzar el trabajo.

"Mi nombre es ___ y hoy estoy aquí para ofrecerle mi ayuda. Primero, y solo si usted desea hablar de ello, vamos a conversar sobre lo que le ha pasado. Luego, si Ud. lo acepta, le enseñaré algunas sencillas técnicas de relajación que le serán muy útiles. Finalmente, veremos en conjunto cómo puede acceder a algunos servicios sociales según sean sus necesidades. ¿De acuerdo, alguna pregunta?... ¿Quisiera contarme algo?".

B

reentrenamiento de la (B)entilación

Ofrezca técnica de respiración y aplíquela por 10 min adaptando a necesidades de la persona. Recuerde dejar instrucciones de continuar usándola en la casa tres veces al día (mañana, tarde, noche, por 10 min cada vez) más cada vez que se sienta desbordado emocionalmente.

"Quizás yo podría ayudarlo(a) a estar un poco más tranquilo(a) luego de lo que Ud. ha vivido con algunos ejercicios de respiración que podría enseñarle. ¿Le gustaría que los practiquemos?... podrá utilizarlos más tarde en su casa si lo desea, lo que podría ayudarlo(a) a estar más tranquilo(a) en los próximos días también".

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)

C

Categorización de necesidades

Identifique y ordene necesidades básicas (agua, comida, abrigo, techo, salud, información, protección, conexión con redes de apoyo...).

"Me gustaría saber si quizás hay algo que Ud. esté necesitando en este momento en lo que yo pueda ayudarle... tal vez necesite hablar con su familia, o quizás necesite contactar a carabineros, o información respecto a su situación de salud. Intentemos poner en orden lo que necesita para ir paso a paso solucionando los problemas, partiendo primero por lo más urgente, ¿le parece?".

D

Deivación a redes de apoyo

Ayude a satisfacer necesidades básicas utilizando el material *"Servicios y Redes de Apoyo".*

"OK... ahora que hemos visto algunas de sus necesidades, me gustaría contactarlo con algunos servicios específicos que podrían serle de ayuda...".

E

psico-Educación

Trabaje junto al afectado el material de psicoeducación y explíquelo: *"¿Qué puedo hacer frente a una crisis?".*

"Ahora, quisiera entregarle este folleto [pasarle el folleto informativo], el cual contiene información sobre psicoeducación en crisis, además de algunos contactos importantes con instituciones y redes de servicio psicológico y legal que puedan brindarle ayuda si llega a necesitarla a futuro." "Por ejemplo, aquí [señalar] usted podrá encontrar información sobre lo que puede esperar durante los días que vienen...".

Bibliografía

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

Arechabala Mantuliz, M. C., & Miranda Castillo, C. (2002). Validación de una escala de apoyo social percibido en un grupo de adultos mayores adscritos a un programa de hipertensión de la Región Metropolitana. *Ciencia y enfermería*, 8(1), 49-55.

Bisson, J. I., & Lewis, C. (2009). Systematic review of psychological first aid. Geneva: WHO.

·Bonanno, G. A., Westphal, M., & Mancini, A. D. (2011). Resilience to loss and potential trauma. *Annual review of clinical psychology*, 7, 511-535.

Breslau, N. (2001). The epidemiology of posttraumatic stress disorder: What is the extent of the problem? *The Journal of Clinical Psychiatry, 62, Suppl* 17, 16-22.

Carlson, E. B., Smith, S. R., Palmieri, P. A., Dalenberg, C., Ruzek, J. I., Kimerling, R., ... & Spain, D. A. (2011). Development and validation of a brief self-report measure of trauma exposure: the Trauma History Screen. *Psychological assessment*,23(2), 463.

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE - 10) (s.f). Consultado el 13 de agosto de 2015, de http://ais.paho.org/classifications/Chapters/

Dieltjens, T., Moonens, I., Van Praet, K., De Buck, E., Vekerckhove, P. (2014) A systematic literature search on psychological first aid: Lack of evidence to develop guidelines. *PLoS ONE*,9(12),e114714.

Everly, G. S., & Mitchell, J. T. (2000). The debriefing "controversy" and crisis intervention: A review of lexical and substantive issues. *International Journal of Emergency Mental Health,* 2(4), 211-226.

Figueroa RA, Cortés PF, Accatino L, Sorensen R. (2016). Trauma psicológico en la atención primaria: Orientaciones de manejo. *Revista Médica de Chile*, 144: 643-655

Figueroa, R. A., Repetto, P., & Bernales, M. (2014). [Incorporation of psychological first aid to the undergraduate curriculum]. *Revista Médica De Chile*, 142(7), 934-5.

Flannery, R. B., & Everly, G. S. (2000). Crisis intervention: A review. *International Journal of Emergency Mental Health*, 2(2), 119-126.

Friedman MJ, Resick PA, Bryant RA, Brewin CR. (2011). Considering PTSD for DSM-5. Depression and Anxiety, 28(9):750-69.

Foa E., Hembree E., Rothbaum BO. (2007). *Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences therapist guide*. Oxford University Press.

Fox, J.H., Burkle, F.M., Bass, J., Pia, F.A, Epstein, J.L., Markenson, D. (2012) The effectiveness of psychological first aid as a disaster intervention tool: research analysis of peer-reviewed literature from 1990-2010. *Disaster Medicine Public Health Preparation*,6(3):247–52.

Gartlehner, G., Forneris, C.A., Brownley, K.A., Gaynes, B.N., Sonis, J., Coker-Schwimmer, E., et al. (2013) *Interventions for the Prevention of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults After Exposure to Psychological Trauma*. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US).

Green, B. L., Lindy, J. D., Grace, M. C., & Leonard, A. C. (1992). Chronic posttraumatic stress disorder and diagnostic comorbidity in a disaster sample. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 180(12), 760-6.

Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. A., Brymer, M. J., Friedman, M. J., . . . Ursano, R. J. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry*, 70(4), 283-315.

Hoge, E. A., Worthington, J. J., Nagurney, J. T., Chang, Y., Kay, E. B., Feterowski, C. M., . . . Pitman, R. K. (2012). Effect of acute posttrauma propranolol on PTSD outcome and physiological responses during script-driven imagery. *CNS Neuroscience & Therapeutics*, 18(1), 21-7.

Kessler, R. C. (2000). Posttraumatic stress disorder: The burden to the individual and to society. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 61 Suppl 5, 4-12.

Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity survey. *Archives of General Psychiatry*, 52(12), 1048-60

Ministerio de Salud de Chile (2008). Estudio de carga de enfermedad y carga atribuible, en: http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/cargaenf2008/minuta21-07-2008.pdf.

Norris, F. H., Murphy, A. D., Baker, C. K., Perilla, J. L., Rodriguez, F. G., & Rodriguez, J. d. e. . J. (2003). Epidemiology of trauma and posttraumatic stress disorder in mexico. *Journal of Abnormal Psychology*, 112(4), 646-56.

Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation, & Visión Mundial Internacional. (2012). Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo. Ginebra: OMS.

Ozer, E. J., Best, S. R., Lipsey, T. L., & Weiss, D. S. (2003). Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: A meta-analysis. *Psychological Bulletin, 129*(1), 52-73.

Perkonigg, A., Kessler, R. C., Storz, S., & Wittchen, H. U. (2000). Traumatic events and post-traumatic stress disorder in the community: Prevalence, risk factors and comorbidity. *Acta Psychiatrica Scandinavica, 101*(1), 46-59.

PTSD: National Center for PTSD - Reacciones Comunes después de un trauma (2015). Consultado el 28 de diciembre de 2015, en http://www.ptsd.va.gov/public/spanish/common_reactions_after_trauma_spanish.asp

Ramos-Brieva J A, Cordero Villafáfila A. (1986). Validación de la versión castellana de la escala de Hamilton para la depresión. *Actas Luso-Esp Neurol Psiquiatr*, 14: 324-34.

Rose, S., Bisson, J., Churchill, R., & Wessely, S. (2002). Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD000560.

Rothbaum, B. O., Kearns, M. C., Price, M., Malcoun, E., Davis, M., Ressler, K. J., . . . Houry, D. (2012). Early intervention may prevent the development of posttraumatic stress disorder: A randomized pilot civilian study with modified prolonged exposure. *Biological Psychiatry,* 72(11):957-63

Schelling, G., Roozendaal, B., Krauseneck, T., Schmoelz, M., DE Quervain, D., & Briegel, J. (2006). Efficacy of hydrocortisone in preventing posttraumatic stress disorder following critical illness and major surgery. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1071, 46-53.

Stein, M. B., McQuaid, J. R., Pedrelli, P., Lenox, R., & McCahill, M. E. (2000). Posttraumatic stress disorder in the primary care medical setting. *General Hospital Psychiatry, 22*(4), 261-9.

Vázquez, C., Sanz, J. (1999). Fiabilidad y validez de la versión española del Inventario para la Depresión de Beck de 1978 en pacientes con trastornos psicológicos. *Clínica y Salud*, *10,* 58-81.

Vera-Villarroel, P., Zych, I., Celis-Atenas, K., Córdova-Rubio, N., & Buela-Casal, G. (2011). Chilean validation of the posttraumatic stress disorder checklist-civilian version (PCL-C) after the earthquake on february 27, 2010. *Psychological Reports, 109*(1), 47-58.

Wade, D., Howard, A., Fletcher, S., Cooper, J., Forbes, D. (2013) Early response to psychological trauma—what GPs can do. *Australian Family Physician,42*(9):610–4.

Watson P.J.,Brymer M.J.,Bonanno G.A. (2011). Postdisaster psychological intervention since 9/11. *American Psychologist, 66*(6):482-494.

Zlotnick, C., Johnson, J., Kohn, R., Vicente, B., Rioseco, P., & Saldivia, S. (2006). Epidemiology of trauma, post-traumatic stress disorder (PTSD) and co-morbid disorders in chile. *Psychological Medicine, 36*(11), 1523-33.

Recursos en línea

is.gd/primerosauxiliospsicologicos
Serie de 6 vídeos breves donde se explican y demuestran los fundamentos y pasos de los PAP.

www.educacioncontinua.uc.cl

Sitio web de los Programas de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la sección *"Cursos Seminarios"* - Facultad de Medicina, podrá encontrar información sobre el *Taller de Primeros Auxilios Psicológicos*.

is.gd/introduccionaltrauma

Documento actualizado que expone una revisión amplia sobre trauma psíquico, sus secuelas y su tratamiento, desarrollado por la Unidad de Trauma y Disociación (UTD) del Departamento de Psiquiatría UC.

www.sochped.cl/videos

Sitio web de la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres (SOCHPED). Aquí es posible encontrar videos breves sobre recomendaciones prácticas para cuidar la salud mental de niños, adultos, profesionales y voluntarios en situaciones de crisis.

www.emdrchile.cl

Sitio web de la Terapia de EMDR en Chile. Aquí encontrará información sobre la terapia psicológica, profesionales acreditados y vías de contacto para solicitar atención especializada.

www.emsworld.com/article/12077165/evidence-for-psychological-first-aid

Sitio web (en inglés) de la revista EMS-WORLD (Emergency Medical Services). Se presenta una revisión sobre los PAP, enfocándose en la evidencia disponible desde diversas revisiones sistemáticas.

www.info-trauma.org

Sitio web (en inglés) del Douglas Mental Health Institute y de la Universidad de McGill, en donde se provee de información relevante acerca del trauma psíquico en formato multimedia e interactivo.

www.ptsd.va.gov/public/treatment/therapy-med/

Sitio web (en inglés y español) del Centro Nacional para el TEPT de los Estados Unidos de América. Se describen los diferentes tratamientos recomendados para el TEPT y sus características, además de recursos online para aprender sobre el tema.

www.minmujeryeg.gob.cl

Sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAM). Aquí podrá encontrar las direcciones de las oficinas regionales, además de información relevante como Programas para la Mujer, ayuda y orientación telefónica en violencia contra las mujeres, estudios de género, entre otros recursos.

www.investigaciones.cl

Sitio web de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se puede encontrar información sobre diversos delitos y violencia (homicidios, robos, violencia intrafamiliar, entre otros). Se pone especial énfasis en el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS). En la sección *"descargas"* están disponibles algunos recursos gráficos sobre el tema.

www.sename.cl

Sitio web del Servicios Nacional de Menores (SENAME). En este link están disponibles los teléfonos de emergencia frente a violencia contra niños y jóvenes, además de información programas de prevención y protección. Al respecto, es posible encontrar los datos de contacto de las distintas Oficinas de Protección de Derechos (OPD), a lo largo de Chile.

www.isl.gob.cl/

Sitio web del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), entidad encargada de administrar la información sobre procedimientos relacionados con las condiciones laborales que pueden generar daño a las personas. Aquí es posible encontrar recursos sobre prevención de riesgos, red de prestadores médicos, accidentes laborales

o enfermedades profesionales, entre otros.

www.fundacionemilia.cl

Sitio web de la Fundación Emilia, organización que busca apoyar a los familiares de víctimas de accidentes viales producto de la conducción irresponsable, vinculados a la llamada Ley Emilia. Se dispone del contacto para apoyo personal, psicológico y jurídico a las víctimas.

www.dsp.gov.cl/programa-apoyo-a-victimas-de-delito/

Sitio web de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde es posible encontrar información relacionada con el Programa de Apoyo a Víctimas del Delito, como servicios, red de asistencia, ubicación y estudios del tema, entre otros.

www.cigiden.cl

Sitio web del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN).

Glosario y términos

Los siguientes conceptos son comúnmente utilizados en situaciones de crisis individual y colectiva. Algunos hacen referencia a intervenciones preventivas y otras de reparación.

Critical Incident Stress Debriefing (CISD)

Es un tipo de intervención en crisis que se realiza en forma grupal, centrada en la discusión de un evento traumático, cuyo objetivo es la disminución del estrés y la restauración de la cohesión grupal mediante el uso de la catarsis. Puede ser descrito también como un proceso psicoeducativo en el que se cuenta la historia y experiencia del evento traumático, combinada con la entrega de información práctica para normalizar las reacciones de estrés y así facilitar su recuperación. A pesar de que su uso podría parecer razonable y apela al sentido común sobre lo que podría ayudar a los afectados, existen ensayos clínicos que desaconsejan su utilización porque no han encontrado que sea efectivo e incluso podría tener un efecto iatrogénico al aumentar la incidencia de TEPT (Rose, Bisson, Churchill & Wesseley, 2002).

Desensibilización y Reprocesamiento por el Movimiento Ocular o *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR)

Es una terapia integrativa que incluye elementos de distintos enfoques psicoterapéuticos, tales como el cognitivo-conductual, sistémico, psicodinámico, experiencial y otros. Es empleado para resolver de manera integral el material emocional perturbador derivado de eventos traumáticos y también como un medio para potenciar estados emocionales positivos, con el fin de facilitar el crecimiento natural y el proceso curativo. Se basa fundamentalmente en la comprensión de que el funcionamiento perturbado del paciente surge de experiencias traumáticas, la mayoría de ellas de la infancia, que no han sido adecuadamente procesadas, debido al modo atípico en que estos recuerdos quedan almacenados en el cerebro. Es un tratamiento de ocho fases, en el que la estimulación bilateral alternada (visual – semejante al del sueño REM, auditiva o táctil) facilitaría la desensibilización y reprocesamiento de recuerdos traumáticos (más información en *www.emdrchile.cl*).

Resiliencia (Individual)

Se refiere a la capacidad de mantener y/o recuperar precozmente el funcionamiento saludable a lo largo del tiempo luego de un incidente crítico, así como la capacidad para generar experiencias y emociones positivas, por lo que es el resultado de un proceso exitoso de adaptación frente a un evento adverso (Bonanno, Westphal y Mancini, 2011).

Terapia Cognitivo Conductual Centrada en el Trauma (TCC-CT)

Es un tipo de psicoterapia que busca generar un cambio emocional a través de la exposición sistemática al recuerdo traumático en un ambiente seguro y el análisis de los pensamientos disfuncionales asociados al recuerdo. A lo largo de las sesiones el paciente aprende a modificar su respiración para lograr un estado de calma, efectúa "*tareas*" que permiten una exposición paulatina al recuerdo traumático y con la ayuda del terapeuta identifica, cuestiona y modifica sus pensamientos, significados e interpretaciones distorsionadas con respecto al evento. Algunas técnicas utilizadas son la reestructuración cognitiva, relajación, afrontamiento y/o exposición *in vivo* e imaginaria, entre otras. Se intenta además promover el pensamiento positivo en relación a la experiencia vivida.

Trauma

Experiencia de riesgo de muerte, lesiones físicas graves o violencia sexual, ya sea como víctima directa, testigo, familiar de la víctima o profesional interviniente. Las causas más frecuentes de trauma en nuestra realidad son experiencias médicas extremas o muy dolorosas, accidentes (de tránsito u otros), abuso sexual, delincuencia, enterarse repentinamente de la muerte, enfermedad o accidente grave de un ser querido o desastres naturales. En un sentido más amplio, también pueden considerarse "traumas" otras experiencias fuertemente estresantes desde el punto de vista subjetivo, como algunos procedimientos médicos, la muerte de una mascota o atorarse fuertemente con la comida. En cualquier caso lo central del trauma es que la experiencia es extremadamente estresante para la persona y percibe que no tiene control sobre ésta.

Trastorno de Estrés Agudo (TEA)

Según el CIE-10 (F43.0), puede definirse como una reacción transitoria al estrés provocado por un evento excepcional que afecta el plano psíquico y físico y que dificulta la capacidad adaptativa de la persona. Los síntomas se configuran en un cuadro de presentación cambiante, y por lo general remiten en el plazo de horas o días. Puede manifestarse en un estado inicial de aturdimiento cognitivo, con cierta constricción del campo de la conciencia y con estrechamiento de la atención, incapacidad para captar estímulos y desorientación. También puede haber presencia de reacciones del sistema nervioso autónomo, como signos de pánico (taquicardia, sudor, rubor). Si los síntomas persisten en el tiempo y en intensidad, debe considerarse un cambio de diagnóstico por TEPT.

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)

Según el CIE-10 (F43.1), puede definirse como una respuesta tardía a un evento estresante de naturaleza amenazante o catastrófica, situación que causaría reacciones de angustia generalizada en casi cualquier persona. Se observan episodios vívidos como una repetición del trauma a través de pensamientos intrusivos, sueños o pesadillas, experimentados en un fondo de aplanamiento emocional, desapego, anhedonia, y un estado de alerta excesiva y persistente (hipervigilancia, insomnio). La ansiedad y la depresión se asocian con frecuencia al resto de los síntomas, siendo frecuente la presencia de ideación suicida. El comienzo del trastorno sigue a la ocurrencia del evento traumático, con periodos de latencia que varían entre semanas a meses, e incluso años.

Servicios y
Redes de Apoyo

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

CIGIDEN
Centro de Investigación
para la Gestión Integrada
del Riesgo de Desastres

Centros de Apoyo a Víctimas

Contacto

Número de atención nacional: *600 818 1000*

Página web: *www.seguridadpublica.gov.cl/programa-apoyo-a-victimas-de-delito/*

También puede buscar ayuda en:
www.fundacionemilia.cl
contacto@fundacionemilia.cl

Aquí se proporciona gratuitamente intervención especializada e interdisciplinaria (psicológica, social y jurídica), de carácter presencial, para aquellos casos que experimentan mayor daño a consecuencia de un delito, así como también en casos de accidentes de tránsito como consecuencia del alcohol (Ley Emilia).

Servicios del Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Contacto

ISL Puede dirigirse a la Dirección Regional según su domicilio o llamar al teléfono único nacional *600 586 9090*

Horario de atención: Lunes a jueves 8:30 a 15:30 hrs. y viernes hasta las 14:00 hrs.

Página web: *www.isl.gob.cl/inicio/accidentes-y-enfermedades-laborales/*

En caso de haber tenido un accidente laboral, esta información puede serle útil.

¿Qué hacer en caso de...?

Accidente leve: El trabajador debe informar a su jefe o supervisor sobre la situación y solicitar atención médica. El empleador debe formalizar la Denuncia Individual de Accidente de Trabajo (DIAT) en el Instituto de Seguridad Laboral.

Accidente grave: El trabajador debe recibir atención médica inmediata. El empleador debe entregar Formulario de *Notificación Inmediata de Accidente del Trabajo Fatal y Grave* y formalizar la Denuncia Individual de Accidente de Trabajo (DIAT) en el Instituto de Seguridad Laboral.

Prestaciones médicas:

- Atención médica, quirúrgica o dental en establecimientos externos o a domicilio.
- Hospitalización si fuera necesario, a juicio del facultativo tratante.
- Medicamentos y productos farmacéuticos.
- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
- Rehabilitación física y reeducación profesional.
- Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.

Trabajador Dependiente: Frente a ninguna de ambas situaciones el trabajador percibirá descuentos por las horas o días perdidos producto del accidente ni por el tiempo de recuperación (licencia médica).

Su atención es cubierta por el seguro social contra riesgo de accidentes y enfermedades profesionales (Ley 16.744)

Trabajador Independiente: Debe estar al día en el pago del seguro. Si no está al día o no se encuentra afiliado al seguro, la atención médica cuenta como accidente común.

Garantías Explícitas en Salud (GES)

Contacto

Página web:
www.supersalud.gob.cl/servicios

Los gastos de salud producto de algunas enfermedades catastróficas están cubiertos por las Garantías Explícitas de Salud (antiguamente AUGE). En caso de haber sido notificado de una enfermedad GES, ya sea por su gravedad o costo económico, esta información puede ser de su interés.

Algunas enfermedades graves cubiertas por el GES

- Accidente cerebrovascular isquémico
- Infarto agudo al miocardio
- Politraumatismo grave
- Atención de urgencia por traumatismo cráneo-encefálico moderado o grave
- Gran quemado

¿Cómo hago efectiva las garantías del GES?

Si padece alguna de las patologías GES, debe acercarse a FONASA o su ISAPRE con el certificado médico que acredite el diagnóstico y llenar un formulario creado para estos efectos. Allí le indicarán a qué prestador debe acudir para confirmar el diagnóstico. Si se confirma, será derivado al centro de atención de la red de prestadores en convenio con su institución previsional de salud.

Salud Responde

Contacto

Número de atención:
600 360 7777

Página web: *http://web.minsal.cl/salud_responde*

Salud Responde es la plataforma telefónica del Ministerio de Salud encargada de brindar información, apoyo y educación en salud a todo el país, las 24 horas del día durante todo el año.

Está compuesto por un equipo multidisciplinario (médicos, enfermeras, matronas y psicólogos entre otras) y se enfoca en orientar a los usuarios respecto a los derechos y beneficios que ofrece la red de salud.

Algunos servicios

Consultas de Salud: Atención telefónica de consultas relacionadas a problemas o dudas de salud del usuario o su familia, que requieren de apoyo profesional, momento en el cual se orienta según los síntomas y se dan las instrucciones para manejo en casa o derivación a red asistencial, en caso de ser necesario.

Asistencia en Urgencias de Salud: En caso de urgencia, un profesional de la salud le brindará atención inmediata vía telefónica, indicando los primeros auxilios, y de ser necesario realizará la coordinación para el traslado a un centro asistencial.

Apoyo en Situaciones de Emergencias y Desastres: En caso de situaciones de emergencias y desastres, se entrega orientación para la prevención de enfermedades: primeros auxilios, manejo del agua y de los alimentos, apoyo y contención emocional, entre otros.

FONASA (Fondo Nacional de Salud)

Contacto

Número de atención:
600 360 3000

Horario de atención: Lunes a jueves desde 8:40 a 16:30 hrs. en horario continuado, y viernes hasta las 14:00 hrs.

Más información en:
www.fonasa.cl

Usted puede acercarse para realizar consultas y trámites a cualquiera de las oficinas de FONASA a lo largo del país.

Recuerde que la mayoría de los trámites pueden realizarse online en *www.fonasa.cl*

Defensoría Penal Pública (DPP)

Contacto

Número de atención:
(2) 2439 6800

Página web:
www.dpp.cl/index

Usted también puede necesitar abogados. A través de la Defensoría Penal Pública se garantiza el derecho de las personas a contar con un abogado defensor, de manera que se apliquen los principios del proceso penal: que todo imputado sea tratado como inocente; que esté garantizado el juicio previo; que éste cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista frente a las imputaciones que se le formulan y que, cuando corresponda, se le aplique una sanción justa.

La defensa es gratuita para quienes no cuenten con medios económicos.

Notas

¿Qué debo esperar frente a una crisis?

Reacciones normales (esperables):

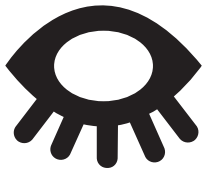
Temblores, dolores de cabeza, sensación de agotamiento, pérdida de apetito.

Ansiedad, estar "en guardia", miedo.

Llanto, tristeza, decaimiento.

"Guardarse todo para dentro", estar muy quieto.

Irritabilidad, enojo.



Insomnio, pesadillas.

Es esperable que estos síntomas disminuyan con el paso de los días y que al cabo de semanas ya no estén presentes. Todos son normales, por lo que no son una señal de que usted esté con un problema de salud mental.

Es importante ayudarse con las siguientes estrategias de respuesta positivas frente al estrés:

✓ Intente descansar *(entre 7 a 8 horas continuas en la noche)*.

✓ Recuerde utilizar las técnicas de respiración.

✓ Comparta con familia y amigos.

✓ Realice actividades que le ayuden a relajarse: caminar, rezar, meditación, salir en bicicleta, etc.

✓ Intente realizar actividad física recurrente *(4 o más veces por semana)*.

✓ Procure establecer rutinas de actividades diarias.

✓ Evite el consumo de alcohol o drogas.

Aún siguiendo estas recomendaciones, en ciertas personas los síntomas no se irán fácilmente. Identifique si quizás:

· Los signos y síntomas se mantienen o aumenta su intensidad después de un mes del evento.

· Cree que perdió la capacidad de cuidar de sí mismo (dejar de bañarse o comer) o de otros (bebés, niños).

· Es atormentado recurrentemente por imágenes o recuerdos del evento traumático.

· Tiene la sensación de *"no poder dar vuelta la página"*

· Se desconecta de sus emociones y recuerdos.

· Se aísla de sus seres queridos.

Si es así, usted debe acercarse a su centro de salud habitual y solicitar atención médica, por un médico o psicólogo/a. Este tipo de reacciones tienen buen tratamiento cuando se abordan a tiempo.

¿Dónde pedir Ayuda?

→Consultorio Municipal o centro médico.

→Centro de Apoyo a Víctimas *600 818 1000*

→Instituto de Seguridad Laboral *600 586 9090*

→Centro de la Mujer (SERNAM) *800 104 008*

→Defensoría Penal Pública *(2) 2439 6800*

→Salud Responde *600 360 7777*

→FONASA *600 360 3000*

→Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales *(2) 2708 1668*

→Orientación sobre maltrato infantil *800 730 800*

→SAMU *(131)*

→BOMBEROS *(132)*

→CARABINEROS *(133)*

→Policía de Investigaciones *(134)*

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

CIGIDEN
Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

CIGIDEN

Centro de Investigación
para la Gestión Integrada
del Riesgo de Desastres

BIBLIOGRAFÍA

- CORTÉS MONTENEGRO, P. y FIGUEROA CABELLO, R. (2016) *Manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos en crisis individuales y colectivas*. Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.[1]

[1] Uso con fin académico.